Estilo UERJ

Simulado 13 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	15	3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 26, 35, 39, 41, 47
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	4	7, 29, 43, 45
Dado omitido	o achado mais famoso foi retirado	1	15
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	2	11, 50
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	8	1, 4, 22, 23, 27, 32, 44, 49
Qualificador	o comando restringe o que se pede	4	30, 36, 37, 46
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	3	20, 38, 40
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	5	6, 28, 31, 42, 48
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	8	2, 14, 16, 18, 19, 25, 33, 34

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante em 15/10/2026.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **B**	3 **A**	4 **A**	5 **D**	6 **C**	7 **B**	8 **B**	9 **C**	10 **B**
11 **B**	12 **A**	13 **B**	14 **B**	15 **D**	16 **A**	17 **A**	18 **C**	19 **C**	20 **B**
21 **C**	22 **A**	23 **D**	24 **C**	25 **B**	26 **A**	27 **C**	28 **B**	29 **B**	30 **D**
31 **A**	32 **A**	33 **C**	34 **C**	35 **B**	36 **D**	37 **D**	38 **A**	39 **D**	40 **D**
41 **D**	42 **C**	43 **D**	44 **A**	45 **B**	46 **D**	47 **D**	48 **A**	49 **C**	50 **C**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1

Reumatologia · Fibrose retroperitoneal com hidronefrose bilateral e hipercalemia: derivação urinária primeiro, glicocorticoide para a doença, e IgG4 normal não muda nada

Grade X / Y

Gabarito A

Homem de 63 anos procura a emergência por dor lombar surda há 4 meses, perda de 6 kg e oligúria há 3 dias. Nega uso de derivados do ergot. Tomografia sem contraste: manto de tecido mole envolvendo a aorta abdominal infrarrenal e as ilíacas comuns, que traciona os ureteres medialmente, com hidronefrose bilateral moderada; sem linfonodomegalias em outras cadeias e sem massa pélvica. Exame físico: PA 150 × 92 mmHg, sem edema pulmonar. Exames: creatinina 5,8 mg/dL (0,9 mg/dL há 1 ano), potássio 6,1 mEq/L, pH 7,29, bicarbonato 17 mEq/L, VHS 76 mm/h, IgG4 sérica 98 mg/dL (VR até 135). ECG sem alterações. A conduta imediata e o tratamento da doença de base são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

hidronefrose bilateral moderada

Resolução. Fibrose retroperitoneal periaórtica com ureteres desviados medialmente, sem massa e sem linfonodos, é a forma idiopática, frequentemente parte da doença relacionada à IgG4; a IgG4 sérica é normal em até metade desses casos e não afasta nem muda o tratamento. Como o corticoide reduz a massa, a armadilha é tratar só com ele e esperar. Mas há insuficiência renal pós-renal com hipercalemia e acidose: a conduta imediata é desobstruir (cateter duplo J ou nefrostomia bilateral), o que corrige potássio e acidose sem diálise. Depois, glicocorticoide é a primeira linha para a fibrose; rituximabe e tamoxifeno ficam para recidiva ou intolerância, e ureterólise para falha clínica.

A) Derivação urinária bilateral / glicocorticoide CORRETA

Correta. Desobstrução corrige a lesão pós-renal; o glicocorticoide é a base do tratamento da fibrose.

B) Hemodiálise de urgência / rituximabe

Errada. Hipercalemia de 6,1 sem alteração no ECG com obstrução tratável não exige diálise; rituximabe não é primeira linha.

C) Glicocorticoide isolado / ureterólise se falhar ARMADILHA

Errada. Seria aceitável sem obstrução significativa; com creatinina de 5,8 e hipercalemia, desobstruir não pode esperar.

D) Ureterólise cirúrgica / tamoxifeno

Errada. Cirurgia é reservada à falha do tratamento clínico; tamoxifeno é segunda linha.

Para levar. Fibrose retroperitoneal com uropatia obstrutiva: desobstruir primeiro, glicocorticoide depois; IgG4 sérica normal não afasta a doença relacionada à IgG4.

Vaglio A, Maritati F. Idiopathic retroperitoneal fibrosis (J Am Soc Nephrol, 2016); International Consensus Guidance on IgG4-related disease (Arthritis Rheumatol, 2015).

2

Pneumologia · Reabilitação pulmonar após exacerbação de DPOC: começar nas 4 semanas após a alta, e não durante a internação

Cronologia **Gabarito B**

Em paciente com DPOC internado por exacerbação, o programa de reabilitação pulmonar estruturado (exercício supervisionado) traz maior benefício em readmissões e mortalidade quando iniciado:

O DADO QUE DECIDE

internado por exacerbação

Resolução. A intuição de que mais cedo é melhor leva à internação, mas o ensaio que testou reabilitação iniciada durante a hospitalização (Greening, BMJ 2014) não reduziu readmissões e mostrou mortalidade maior em 12 meses. O benefício (menos readmissões, menor mortalidade, melhor qualidade de vida) aparece quando o programa começa logo depois da alta, dentro de 4 semanas; esperar 3 meses perde a janela em que o descondicionamento pós-exacerbação é maior. Durante a internação cabe mobilização precoce e fisioterapia, não o programa estruturado. A indicação independe do VEF1: vale para todo DPOC sintomático ou com exacerbação recente.

A) Após 3 meses de estabilidade
Errada. Seria a lógica de esperar estabilidade, mas perde a janela de maior benefício após a exacerbação.

B) Até 4 semanas após a alta CORRETA
Correta. Iniciada nas 4 semanas após a alta, reduz readmissões e mortalidade.

C) Ainda durante a internação ARMADILHA
Errada. O programa estruturado iniciado na internação não reduziu readmissões e associou-se a maior mortalidade; ali cabe só mobilização.

D) Apenas se VEF1 abaixo de 50%
Errada. A indicação é por sintomas e exacerbação recente, não por limiar de VEF1.

Para levar. Reabilitação pulmonar pós-exacerbação de DPOC: dentro de 4 semanas após a alta. Na internação, só mobilização precoce.

GOLD 2025 (manejo pós-exacerbação); ATS/ERS Statement on Pulmonary Rehabilitation (2013, atualizações); Greening NJ et al., BMJ 2014.

3

Gastroenterologia · Febre, leucopenia e aminotransferases em milhares com bilirrubina quase normal no terceiro trimestre: hepatite por herpes simples, e não esteatose aguda da gestação

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Gestante de 31 anos, primigesta, com 32 semanas, procura a emergência por febre de 39,1 °C há 4 dias, mialgia, odinofagia e dor em hipocôndrio direito. Nega prurido, cefaleia e escotomas. Pré-natal sem intercorrências; usa apenas sulfato ferroso e nega paracetamol. Sem lesões orais ou genitais ao exame. PA 112×68 mmHg, FC 112 bpm, sem edema, sem asterixe. Exames: AST 4.850 U/L, ALT 3.920 U/L, bilirrubina total 1,1 mg/dL, leucócitos 2.300/mm³, plaquetas 96.000/mm³, INR 1,6, glicemia 88 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL, haptoglobina normal, esfregaço sem esquistócitos, proteinúria negativa. Anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM e anti-HCV não

reagentes. Ultrassonografia: fígado de tamanho normal, sem esteatose, vias biliares normais; feto com vitalidade preservada. A etiologia mais provável da hepatite é:

O DADO QUE DECIDE

bilirrubina total 1,1 mg/dL, leucócitos 2.300/mm³

Resolução. Terceiro trimestre, plaquetopenia e INR alargado formam o cenário em que se pensa primeiro nas doenças hepáticas próprias da gestação, e a esteatose aguda é a que mais atrai pela coagulopatia. Mas as doenças da gestação raramente levam as aminotransferases a milhares: na esteatose aguda e na HELLP elas costumam ficar abaixo de 1.000 U/L, a esteatose aguda traz bilirrubina alta, hipoglicemia e lesão renal (ausentes aqui), e a HELLP exige hemólise e em geral hipertensão (haptoglobina normal, sem esquistócitos, PA normal). Febre alta com pródromo viral, leucopenia, plaquetopenia e aminotransferases em milhares com bilirrubina quase normal (hepatite anictérica) é o desenho da hepatite por herpes simples, que na gestação, sobretudo no terceiro trimestre, tende à forma disseminada e grave, e em boa parte dos casos sem lesão mucocutânea. O diagnóstico muda a conduta: aciclovir intravenoso empírico imediato, sem esperar a PCR para herpes no sangue, porque a mortalidade materna e fetal sem tratamento é alta; e, ao contrário da esteatose aguda e da HELLP, antecipar o parto não trata a doença. A hepatite E grave da gestante é ictérica, com bilirrubina alta.

A) Hepatite por herpes simples CORRETA

Correta. Febre, leucopenia, plaquetopenia e aminotransferases em milhares com bilirrubina de 1,1 mg/dL: hepatite herpética anictérica, que pede aciclovir intravenoso empírico já.

B) Esteatose hepática aguda da gestação ARMADILHA

Errada. É a armadilha: coagulopatia no terceiro trimestre atrai, mas a esteatose aguda traz bilirrubina alta, hipoglicemia e lesão renal, com aminotransferases em geral abaixo de 1.000.

C) Síndrome HELLP

Errada. Seria a resposta com hipertensão, hemólise (esquistócitos, haptoglobina baixa) e aminotransferases em geral abaixo de 1.000; PA e haptoglobina normais a afastam.

D) Hepatite aguda pelo vírus E

Errada. Seria lembrada na gestante vinda de área endêmica do genótipo 1, com hepatite grave e ictérica; bilirrubina quase normal com febre alta e leucopenia não combinam.

Para levar. Gestante com febre, leucopenia e aminotransferases em milhares com pouca icterícia: hepatite por herpes simples até prova em contrário; aciclovir intravenoso empírico sem esperar a PCR, e o parto não é o tratamento.

EASL Clinical Practical Guidelines on the management of acute (fulminant) liver failure (2017); ACG Clinical Guideline: Liver Disease and Pregnancy (2016)

---

4 Hematologia · TRALI com hipotensão, febre e ecocardiograma normal: suporte sem diurético no receptor e investigação de anticorpos na doadora

Grade X / Y Gabarito A

Mulher de 52 anos, sem cardiopatia, com plaquetas de 18.000/mm³ por leucemia em quimioterapia, recebe uma dose de plaquetas por aférese de doadora multípara antes de passagem de cateter. Uma hora após o fim da infusão, apresenta dispneia intensa, SpO2 de 82% em ar ambiente, temperatura de 38,3 °C, PA 86 × 52 mmHg,

FC 124 bpm e estertores difusos. Radiografia de tórax: infiltrado alveolar bilateral novo. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 62%, veia cava inferior de 1,2 cm com colapso inspiratório acima de 50%. BNP 70 pg/mL. Balanço hídrico das últimas 24 horas: negativo em 300 mL. A conduta no receptor e a medida em relação à doadora são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

FE de 62%, veia cava inferior de 1,2 cm com colapso inspiratório acima de 50%

Resolução. Edema pulmonar logo após transfusão faz pensar primeiro em sobrecarga circulatória (TACO), e a resposta automática é furosemida. Mas tudo aqui fala contra sobrecarga: hipotensão e febre (a TACO cursa com hipertensão), ecocardiograma com FE normal e veia cava colapsável, BNP baixo e balanço negativo. É lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão (TRALI), edema por aumento de permeabilidade, em geral causado por anticorpos anti-HLA ou anti-HNA do doador, mais frequentes em mulheres multíparas, dirigidos aos neutrófilos do receptor. O tratamento é suporte: oxigênio, ventilação não invasiva ou invasiva protetora, e volume ou vasopressor se necessário; diurético piora a hipotensão e não ajuda. O caso deve ser notificado à hemovigilância e a doadora investigada para anticorpos anti-HLA e anti-HNA; se positivos, ela é afastada da doação de plasma e plaquetas, o que protege os próximos receptores.

A) Suporte sem diurético / anticorpos anti-HLA e anti-HNA na doadora CORRETA
Correta. TRALI: suporte sem diurético e investigação de anticorpos na doadora, que é afastada se positivos.

B) Suporte sem diurético / nenhuma medida com a doadora
Errada. O suporte está certo, mas deixar de investigar a doadora mantém o risco para os próximos receptores.

C) Furosemida intravenosa / anticorpos anti-HLA e anti-HNA na doadora
Errada. A investigação da doadora está certa, mas diurético em TRALI hipotensa piora a perfusão.

D) Furosemida intravenosa / nenhuma medida com a doadora ARMADILHA
Errada nas duas metades, é a armadilha. Furosemida é para TACO, e TRALI exige investigar o doador.

Para levar. TRALI: febre, hipotensão, FE e BNP normais; tratar com suporte, sem diurético, notificar e investigar anticorpos anti-HLA e anti-HNA no doador.

Vlaar APJ et al., A consensus redefinition of TRALI (Transfusion 2019); ANVISA, Marco conceitual e operacional de hemovigilância: guia para a hemovigilância no Brasil (2015).

---

5 Infectologia · Dispneia no 8º dia de dengue com hematócrito em queda, plaquetas subindo e hipertensão: hipervolemia da fase de recuperação

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 40 anos, hipertensa em uso de losartana (suspensa na internação), foi internada no 5º dia de dengue por dor abdominal intensa e hematócrito de 48%, e recebeu hidratação venosa de cerca de 3 L/dia desde então, mantida por prescrição. Hoje, no 8º dia, está afebril há 36 horas e passou a ter dispneia, ortopneia e tosse seca. Exame: PA 162 × 96 mmHg, FC 90 bpm, FR 28 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, estertores crepitantes bibasais, turgência jugular, edema de membros inferiores. Exames: hematócrito de 33%, plaquetas de 58.000/mm³ (eram 22.000/mm³ há 48 horas), albumina 3,2 g/dL, troponina normal, BNP 620 pg/mL. Radiografia: congestão hilar bilateral e pequenos derrames. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

PA 162 × 96 mmHg

Resolução. Dengue que piora com dispneia e derrames na internação evoca extravasamento plasmático grave, e o reflexo é mais volume ou albumina. Mas a fase crítica (extravasamento) ocorre na defervescência, entre o 3º e o 7º dia, com hematócrito subindo, hipotensão e pulso convergente. Aqui o cenário é o oposto: no 8º dia, afebril há 36 horas, com plaquetas em recuperação, o líquido extravasado está sendo reabsorvido, e a hidratação mantida por prescrição soma volume. O hematócrito em queda por hemodiluição, a hipertensão, a turgência jugular, o BNP alto e a congestão radiológica são de hipervolemia. A conduta é suspender a hidratação venosa e usar diurético, e não expandir. Miocardite cursa com troponina elevada e disfunção, e pneumonia não explica a hipertensão nem o hematócrito.

A) Pneumonia hospitalar

Errada. Seria pensada com febre que retorna e infiltrado localizado; aqui a paciente está afebril, com congestão bilateral e turgência jugular.

B) Miocardite por dengue

Errada. A miocardite da dengue cursa com troponina elevada, arritmia ou hipotensão; a troponina normal e a hipertensão a afastam.

C) Extravasamento plasmático com SDRA ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o extravasamento ocorre na fase crítica, com hematócrito subindo e hipotensão, e não no 8º dia com hematócrito em queda e PA alta.

D) Hipervolemia da fase de recuperação CORRETA

Correta. Fase de recuperação, plaquetas subindo, hematócrito caindo por diluição, hipertensão e congestão com hidratação ainda correndo: hipervolemia.

Para levar. Na dengue, a fase de recuperação reabsorve o que extravasou: dispneia com hipertensão e hematócrito em queda após a defervescência é hipervolemia, e a conduta é suspender o soro e usar diurético.

Ministério da Saúde, Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança, 6ª ed. (2024); OMS, Handbook for clinical management of dengue (2012).

6

Cardiologia · Padrão de Brugada tipo 1 só durante a febre em assintomático: tratar a febre e evitar drogas, sem CDI

Omissão **Gabarito C**

Homem de 34 anos, sem comorbidades, é atendido por síndrome gripal com febre de 39,6 °C há 2 dias. Nunca teve síncope, palpitações, respiração agônica noturna ou crises convulsivas; não há morte súbita ou síncope em parentes de primeiro grau antes dos 45 anos. ECG na admissão, febril: supradesnivelamento do ST de 3 mm em V1 e V2, com morfologia em 'cúpula' e onda T negativa, QRS de 100 ms e QTc de 420 ms. O ECG admissional da empresa, de 1 ano atrás, era normal. Após dipirona e resfriamento, o ECG repetido com 37,0 °C, 12 horas depois, é normal. Ecocardiograma normal; potássio 4,1 mEq/L. Ele vai receber alta. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Nunca teve síncope, palpitações, respiração agônica noturna ou crises convulsivas

Resolução. O padrão de Brugada tipo 1 (supra em cúpula de 2 mm ou mais em V1 e V2 com T negativa) desmascarado pela febre assusta, e o CDI é a isca. Mas o risco de morte súbita no Brugada depende da clínica: o CDI tem indicação em quem sobreviveu a parada cardíaca, teve TV sustentada ou síncope de provável origem arrítmica. No assintomático, e ainda mais com padrão tipo 1 que só aparece com febre (não espontâneo), o risco anual de evento é muito baixo, e a conduta é educação: tratar toda febre precocemente com antitérmico, evitar as drogas que bloqueiam o canal de sódio ou desmascaram o padrão (lista disponível em brugadadrugs.org: antiarrítmicos da classe I, alguns antidepressivos tricíclicos, lítio, propofol em altas doses, cocaína) e evitar excesso de álcool. Estudo eletrofisiológico é, no máximo, considerado no assintomático com padrão tipo 1 espontâneo, que não é o caso.

A) Estudo eletrofisiológico para estratificação
Errada. O estudo eletrofisiológico tem papel discutível e só é considerado no assintomático com padrão tipo 1 espontâneo; com padrão induzido por febre, não acrescenta.

B) Quinidina oral contínua
Errada. A quinidina é usada em tempestade elétrica ou como alternativa em quem tem indicação de CDI e não pode recebê-lo; não é profilaxia de assintomático.

C) Antitérmico precoce e lista de drogas a evitar CORRETA
Correta. Sem sintomas e com padrão só durante a febre, a conduta é tratar a febre precocemente e evitar drogas que desmascaram o padrão.

D) Implante de cardioversor-desfibrilador ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O CDI está indicado no Brugada com parada recuperada, TV sustentada ou síncope arrítmica; no assintomático com padrão induzido por febre, o dano do dispositivo supera o benefício.

Para levar. Brugada: CDI para parada recuperada ou síncope arrítmica. Assintomático, sobretudo com padrão tipo 1 só na febre: antitérmico precoce e lista de drogas a evitar.

ESC 2022 Guidelines for ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death; Expert Consensus Statement on inherited primary arrhythmia syndromes (HRS/EHRA/APHRS 2022)

7

Endocrinologia · Lesão selar e suprasselar cística e calcificada com poliúria hipotônica no adulto: craniofaringioma, e não macroadenoma

Negativo no meio | Gabarito B

Homem de 34 anos procura atendimento por cefaleia frontal progressiva há 8 meses e por esbarrar em objetos dos dois lados. Refere queda da libido e ganho de 6 kg. Nega galactorreia. Na anamnese dirigida, conta que há 6 meses acorda três vezes por noite para urinar e bebe cerca de 5 litros de água por dia, com urina clara. Exame: hemianopsia bitemporal, PA 118 × 74 mmHg. Exames: sódio 145 mEq/L, glicemia 92 mg/dL, osmolalidade urinária 140 mOsm/kg, prolactina 54 ng/mL (referência até 15), testosterona total 140 ng/dL com LH baixo, T4 livre baixo com TSH normal, IGF-1 baixo. Ressonância: lesão selar e suprasselar de 3,2 cm, com componente cístico hiperintenso em T1 e componente sólido; a tomografia mostra calcificações periféricas. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

acorda três vezes por noite para urinar e bebe cerca de 5 litros de água por dia

Resolução. Massa selar grande com hemianopsia bitemporal e hipopituitarismo anterior é a apresentação mais comum do macroadenoma não funcionante, e a prolactina discretamente alta (efeito haste) reforça a impressão: é a armadilha. O dado escondido no meio da anamnese é a poliúria hipotônica (osmolalidade urinária de 140 com sódio de 145), ou seja, diabetes insípido central. Adenoma hipofisário raramente causa diabetes insípido antes da cirurgia, porque cresce de baixo para cima e poupa a neuro-hipófise e o hipotálamo; lesões supraselares que nascem do hipotálamo e da haste, como o craniofaringioma, causam com frequência. A imagem completa: componente cístico com conteúdo rico em proteína e colesterol (hiperintenso em T1), parte sólida e calcificações, presentes na maioria dos craniofaringiomas adamantinomatosos. Prolactina de 54 numa lesão de 3,2 cm afasta macroprolactinoma.

A) Macroadenoma não funcionante ARMADILHA

Errada. É a armadilha: explica a massa, o campo visual e o hipopituitarismo anterior, mas não o diabetes insípido nem as calcificações.

B) Craniofaringioma CORRETA

Correta. Massa suprasselar cística e calcificada com diabetes insípido central e hipopituitarismo: craniofaringioma.

C) Macroprolactinoma

Errada. Macroprolactinoma de 3,2 cm teria prolactina na casa das centenas ou milhares; 54 ng/mL é efeito haste.

D) Hipofisite linfocítica

Errada. Hipofisite pode dar diabetes insípido, mas produz espessamento homogêneo da hipófise e da haste, sem cisto nem calcificação.

Para levar. Diabetes insípido antes da cirurgia numa massa selar afasta o adenoma e aponta lesão hipotalâmica ou de haste: craniofaringioma (cístico e calcificado), metástase, hipofisite ou granulomatose.

Endocrine Society 2016 (Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults); Müller e cols., Craniopharyngioma (Nat Rev Dis Primers 2019).

8

Nefrologia · Dor lombar com hematúria e LDH alta na nefropatia membranosa com albumina baixa · trombose da veia renal, e não infarto renal embólico

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 44 anos, com nefropatia membranosa anti-PLA2R positiva diagnosticada há dois meses (proteinúria de 9 g/24 h, albumina 1,7 g/dL), em uso de losartana e furosemida, aguardando início de rituximabe. Há 12 horas com dor lombar esquerda contínua e urina avermelhada. Afebril, PA 136/84 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, punho-percussão lombar dolorosa à esquerda; na bolsa escrotal, veias dilatadas e tortuosas à esquerda, que não existiam antes e não esvaziam com o decúbito. ECG em ritmo sinusal. Exames: creatinina 1,9 mg/dL (era 1,0 mg/dL), LDH 610 U/L (até 250), hematúria macroscópica, sem leucocitúria nem nitrito. Ultrassonografia sem hidronefrose e sem cálculos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

veias dilatadas e tortuosas à esquerda, que não existiam antes e não esvaziam com o decúbito

Resolução. Dor lombar aguda, hematúria, perda de função e LDH muito alta com urina sem infecção formam o quadro do infarto renal, e a LDH verdadeira puxa para ele. Mas infarto arterial pede fonte embólica, e o ECG está em ritmo sinusal. O dado que decide é a varicocele esquerda nova que não esvazia com o decúbito: a veia gonadal esquerda drena na veia renal esquerda, e a obstrução desta dilata o plexo pampiniforme. Na nefropatia membranosa, sobretudo com albumina abaixo de 2,0 a 2,5 g/dL, o risco de trombose venosa renal é o maior entre as glomerulopatias, pela perda urinária de antitrombina e pelo aumento de fatores pró-coagulantes. A confirmação é por angiotomografia com fase venosa ou Doppler, e o tratamento, anticoagulação plena.

A) Cólica nefrética por cálculo ureteral
Errada. Cálculo daria dor em cólica e, em geral, hidronefrose ou cálculo visível; não explica a varicocele nova nem a LDH tão alta.

B) Trombose da veia renal esquerda CORRETA
Correta. Membranosa com albumina de 1,7 g/dL, dor lombar, hematúria, piora da creatinina e varicocele esquerda nova.

C) Infarto renal por embolia arterial ARMADILHA
Errada. É a isca da LDH; sem fonte embólica (ritmo sinusal) e com varicocele nova, o lado venoso explica melhor o quadro.

D) Pielonefrite aguda
Errada. Afebril, sem leucocitúria nem nitrito; pielonefrite não causa varicocele.

Para levar. Na nefropatia membranosa com albumina baixa, dor lombar com hematúria e varicocele esquerda nova é trombose da veia renal até prova em contrário.

KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases (anticoagulação na síndrome nefrótica).

9

Neurologia · Retenção urinária atribuída ao tramadol na lombociatalgia com anestesia em sela: RM lombossacra de urgência para síndrome da cauda equina

Rótulo verdadeiro | Gabarito C

Homem de 45 anos, pedreiro, com lombociatalgia à esquerda há 3 semanas, tratado com diclofenaco e tramadol 50 mg de 6 em 6 horas, volta ao pronto-socorro porque há 18 horas 'não consegue urinar direito' e precisa fazer força. Refere que a dor piorou e agora irradia para as duas pernas, e uma 'dormência estranha' ao se limpar após evacuar. PA 138/84 mmHg, afebril. Exame: Lasègue positivo a 40 graus bilateralmente, força grau 5 nos membros inferiores, aquileu diminuído à esquerda, hipoestesia tátil e dolorosa na região perineal e na face medial das nádegas, tônus anal diminuído ao toque. Ultrassonografia vesical: resíduo pós-miccional de 620 mL. O residente atribui a retenção ao opioide e propõe sondagem de alívio. Além do cateterismo vesical, o exame mais adequado agora é:

> O DADO QUE DECIDE
> *hipoestesia tátil e dolorosa na região perineal e na face medial das nádegas, tônus anal diminuído ao toque*

Resolução. O opioide é uma causa verdadeira de retenção urinária e oferece uma explicação benigna, e a força normal nas pernas parece tranquilizar. Mas a ciatalgia virou bilateral, há anestesia em sela, tônus anal

reduzido e resíduo de 620 mL: é síndrome da cauda equina, provavelmente por hérnia discal volumosa central, até prova em contrário. A força preservada não afasta, porque as raízes sacrais podem ser comprimidas antes das lombares. O exame é a RM lombossacra de urgência, e confirmada a compressão, a descompressão cirúrgica deve ser feita o quanto antes, idealmente antes da retenção se tornar completa e definitiva. Urodinâmica, ENMG e radiografia atrasam a única decisão que importa.

A) Estudo urodinâmico após suspender tramadol ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Seria razoável numa retenção isolada após iniciar opioide, sem déficit sacral; com anestesia em sela e tônus anal reduzido, esperar é perder função esfincteriana.

B) Eletroneuromiografia dos membros inferiores
Errada. ENMG documenta radiculopatia crônica e não tem lugar na urgência; só mostra desnervação semanas depois.

C) RM de coluna lombossacra de urgência CORRETA
Correta. Ciatalgia bilateral, anestesia em sela, tônus anal reduzido e retenção: RM de urgência e cirurgia se confirmada a compressão.

D) Radiografia dinâmica da coluna lombar
Errada. Radiografia dinâmica avalia instabilidade em espondilolistese, não mostra disco nem raízes.

Para levar. Lombociatalgia com retenção urinária, anestesia em sela ou tônus anal reduzido é síndrome da cauda equina até prova em contrário: RM de urgência, mesmo com força normal e com uma droga que explicaria a retenção.

NICE guideline NG59 (Low back pain and sciatica), atualização 2020; Getting It Right First Time (GIRFT) National Suspected Cauda Equina Syndrome Pathway 2023.

10

Reumatologia · Trombose venosa profunda na doença de Behçet: a trombose é inflamatória, e o tratamento é imunossupressor, não anticoagulação isolada

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 28 anos, com aftas orais recorrentes desde a adolescência, duas úlceras escrotais já cicatrizadas, pseudofoliculite e uveíte posterior tratada há 1 ano, apresenta edema doloroso da perna esquerda há 4 dias. Doppler: trombose venosa femoral e poplítea esquerda. Teve tromboflebite superficial no braço direito há 6 meses. Sem dispneia nem hemoptise; angiotomografia de tórax sem trombos e sem aneurismas de artérias pulmonares. Usa colchicina. Exames: plaquetas 290.000/mm³, função renal normal, anticoagulante lúpico e anticardiolipinas negativos. A conduta mais adequada para a trombose é:

O DADO QUE DECIDE

Teve tromboflebite superficial no braço direito há 6 meses

Resolução. Trombose venosa profunda proximal leva o reflexo à anticoagulação, e o rótulo é verdadeiro. Mas o paciente tem doença de Behçet (aftas, úlceras genitais, pseudofoliculite, uveíte), e a trombose na doença de Behçet nasce da inflamação da parede venosa, recorre e migra (tromboflebite prévia), e o trombo é aderente e pouco embolígeno. Por isso as recomendações EULAR de 2018 tratam a trombose venosa aguda com glicocorticoide e imunossupressor (azatioprina, ciclofosfamida ou ciclosporina), que reduz recorrência;

anticoagulante pode ser associado quando o risco de sangramento é baixo e aneurismas pulmonares foram afastados, mas isolado não basta. Filtro e trombólise não têm papel.

A) Anticoagulação isolada por 3 meses ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na trombose comum; na doença de Behçet, isolada não evita recorrência da trombose inflamatória.

B) Glicocorticoide e azatioprina CORRETA
Correta. Glicocorticoide com imunossupressor é a base do tratamento da trombose venosa da doença de Behçet.

C) Filtro de veia cava inferior
Errada. Não há contraindicação à anticoagulação nem embolia em vigência; filtro pode trombosar.

D) Trombólise dirigida por cateter
Errada. Reservada a trombose maciça com ameaça ao membro, ausente aqui.

Para levar. Na doença de Behçet, trombose venosa é vasculite da parede: glicocorticoide e azatioprina, com anticoagulante apenas como complemento depois de afastar aneurisma pulmonar.

2018 update of the EULAR recommendations for the management of Behçet's syndrome.

11

Hepatologia · MELD elevado em cirrótico compensado que usa varfarina: escore superestimado pelo INR do anticoagulante

Droga a deduzir **Gabarito B**

Homem de 61 anos, com cirrose por doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, nunca descompensou. Tem fibrilação atrial e usa um anticoagulante oral que exige coleta mensal de sangue para ajuste da dose. Exame sem ascite, icterícia ou encefalopatia. Exames: bilirrubina 1,3 mg/dL, albumina 3,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, sódio 136 mEq/L, INR 2,6, plaquetas 118.000/mm³. O MELD calculado é 18. A interpretação correta desse MELD é:

O DADO QUE DECIDE

usa um anticoagulante oral que exige coleta mensal de sangue para ajuste da dose

Resolução. MELD de 18 ultrapassa o limiar de 15 a partir do qual se encaminha o cirrótico para avaliação de transplante, e o reflexo é encaminhar. Mas o MELD é calculado com bilirrubina, creatinina, sódio e INR, e o INR só mede a função de síntese hepática quando não há antagonista da vitamina K. O anticoagulante oral que exige controle mensal do exame é a varfarina, e o INR de 2,6 reflete o alvo terapêutico da fibrilação atrial, não a insuficiência hepática. Com bilirrubina 1,3, albumina 3,9 e nenhuma descompensação, a doença é compensada; o MELD está artificialmente elevado e não deve guiar o encaminhamento, a prioridade em lista nem o prognóstico. A anticoagulação, por sua vez, é indicada e pode ser mantida no cirrótico compensado.

A) Reflete descompensação iminente
Errada. Nada no quadro (bilirrubina, albumina, ausência de ascite e encefalopatia) sugere descompensação; o número alto vem do INR.

B) Está superestimado pelo anticoagulante CORRETA
Correta. A varfarina, deduzida pelo controle mensal de sangue, eleva o INR e superestima o MELD.

C) Contraindica manter a anticoagulação
Errada. A fibrilação atrial indica anticoagulação, e o cirrótico compensado pode mantê-la; o MELD falseado não é contraindicação.

D) Indica avaliação para transplante ARMADILHA
Errada. É a armadilha: MELD acima de 15 indicaria encaminhamento, mas este valor não reflete a função hepática.

Para levar. O MELD não vale em quem usa antagonista da vitamina K: o INR do anticoagulante superestima o escore.

AASLD/AST Practice Guideline: Evaluation for liver transplantation in adults (2013); Kamath PS, Kim WR. The model for end-stage liver disease (MELD). Hepatology (2007)

12

Pneumologia · Hipocalemia com alcalose e hiperglicemia rápida em tabagista com alargamento hilar: ACTH ectópico, apesar do tiazídico

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

Homem de 63 anos, tabagista de 55 maços-ano, hipertenso em uso de hidroclorotiazida 25 mg/dia há 4 anos, procura a emergência por fraqueza progressiva nas pernas há 3 semanas e edema. PA 172/100 mmHg, FC 92 bpm. IMC 23 kg/m², perdeu 6 kg em 2 meses; sem estrias, face arredondada ou giba. Exames: potássio 2,1 mEq/L, bicarbonato 36 mEq/L, sódio 145 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 268 mg/dL (era 92 mg/dL há 6 meses). Radiografia de tórax: alargamento hilar direito. A causa mais provável da hipocalemia é:

O DADO QUE DECIDE
glicemia 268 mg/dL (era 92 mg/dL há 6 meses)

Resolução. O tiazídico causa hipocalemia e alcalose, e é o rótulo verdadeiro que fecha a questão para o apressado. Mas ele está em uso há 4 anos, e a hipocalemia do tiazídico raramente chega a 2,1 mEq/L; o que mudou nas últimas semanas foi hipertensão grave, edema, fraqueza, perda de peso e diabetes surgido em 6 meses. Em tabagista pesado com alargamento hilar, esse conjunto é a secreção ectópica de ACTH (carcinoma de pequenas células ou carcinoide): o cortisol em níveis altíssimos satura a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2 e age como mineralocorticoide. A evolução é rápida demais para o fenótipo cushingoide aparecer; o que domina é a hipocalemia e a hiperglicemia, com emagrecimento pelo tumor. O hiperaldosteronismo primário não explica o diabetes recente nem a perda de peso.

A) Secreção ectópica de ACTH CORRETA
Correta. Hipocalemia grave, alcalose, hipertensão, diabetes de início recente e emagrecimento em tabagista com massa hilar.

B) Efeito da hidroclorotiazida ARMADILHA
Errada. Seria a explicação para hipocalemia leve e estável; não explica glicemia que saltou de 92 para 268 nem o emagrecimento.

C) Hiperaldosteronismo primário
Errada. Causa hipocalemia e alcalose, mas evolui ao longo de anos, sem diabetes súbito nem consumpção.

D) Hipertensão renovascular
Errada. Pode dar hiperaldosteronismo secundário, mas não diabetes recente nem perda de peso, e não se relaciona à massa hilar.

Para levar. Hipocalemia grave com alcalose, hipertensão e hiperglicemia de instalação rápida, sem fenótipo cushingoide, em tabagista: pense em ACTH ectópico; o cortisol em excesso age como mineralocorticoide.

Endocrine Society, Diagnosis of Cushing's Syndrome (2008) e Treatment of Cushing's Syndrome (2015); Pituitary Society Consensus on Cushing's disease (2021).

13

Hematologia · TVP iliofemoral esquerda recorrente na mesma perna com trombofilias negativas: imagem pélvica para compressão da veia ilíaca (May-Thurner)

Rótulo verdadeiro | **Gabarito B**

Mulher de 27 anos, sem comorbidades, teve trombose venosa profunda iliofemoral esquerda há 14 meses, em uso de anticoncepcional oral combinado. Foi anticoagulada com rivaroxabana por 6 meses e o anticoncepcional foi suspenso definitivamente. Pesquisa de trombofilia hereditária e de anticorpos antifosfolípide, feita fora da anticoagulação, foi negativa. Há 5 dias, 8 meses após suspender a rivaroxabana, nova trombose proximal na mesma perna esquerda, que se estende desde a veia ilíaca comum, sem cirurgia, viagem ou imobilização. Hemograma, função renal e hepática e exame ginecológico normais. Já reiniciou anticoagulação. Além de manter a anticoagulação, o próximo exame mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
> *na mesma perna esquerda, que se estende desde a veia ilíaca comum*

Resolução. Trombose recorrente em mulher jovem faz pensar em trombofilia que escapou, e o reflexo é repetir a pesquisa. Mas a pesquisa já foi feita da forma correta (fora da anticoagulação), e repeti-la agora, em vigência de anticoagulante e logo após a trombose, só produz resultados falsos. O lado e a extensão contam a história: duas tromboses iliofemorais, sempre à esquerda, com recorrência após suspender o anticoagulante. A síndrome de May-Thurner (compressão da veia ilíaca comum esquerda entre a artéria ilíaca comum direita e a coluna) predomina em mulheres jovens e se manifesta assim. O exame indicado é imagem da veia ilíaca: venografia por TC ou RM, ou ultrassonografia intravascular, que mostra a compressão e orienta a discussão de recanalização com stent em centro especializado. JAK2 se pesquisa em trombose de sítio incomum (esplâncnico, cerebral) ou com hemograma alterado, e marcadores tumorais não fazem parte do rastreio de neoplasia oculta.

A) Pesquisa da mutação JAK2 V617F
Errada. JAK2 entra na trombose de veias esplâncnicas ou cerebrais e na trombose com eritrocitose ou trombocitose; aqui o sítio é usual e o hemograma é normal.

B) Venografia por TC do abdome e da pelve CORRETA
Correta. TVP iliofemoral esquerda recorrente em mulher jovem sem trombofilia: imagem pélvica para compressão da veia ilíaca.

C) Marcadores tumorais séricos

Errada. Marcadores tumorais não servem para rastrear neoplasia oculta após TVP; e com exame ginecológico e laboratório normais, o rastreio limitado basta.

D) Repetir pesquisa de trombofilia hereditária ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A pesquisa já foi feita fora da anticoagulação; repetir agora daria falsos resultados e não muda a conduta.

Para levar. TVP iliofemoral esquerda, sobretudo recorrente e em mulher jovem, pede imagem da veia ilíaca (TC ou RM venosa, ultrassonografia intravascular) para May-Thurner, e não repetir trombofilia.

ESVS Clinical Practice Guidelines on the management of venous thrombosis (Kakkos et al., 2021); ASH 2023 guidelines on thrombophilia testing.

---

14 Infectologia · Ataque por enxame com centenas de picadas e anafilaxia já revertida: vigiar hemólise, rabdomiólise e lesão renal tardias

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 50 anos, apicultor amador, foi atacado por um enxame ao abrir uma caixa sem proteção há 2 horas e contou cerca de 300 picadas na cabeça, tronco e braços. Chegou com urticária generalizada, sibilância e PA 76 x 40 mmHg; recebeu adrenalina 0,5 mg IM, cristaloide, anti-histamínico e corticoide, com resposta completa. Os ferrões foram retirados por raspagem com lâmina. Agora: PA 128 × 80 mmHg, FC 92 bpm, SpO2 98%, sem sibilos, sem edema de glote, urina clara. Refere dor difusa e mialgia leve. Não tem doença prévia nem usa medicamentos. A família pede alta após as 6 horas de observação habituais da anafilaxia. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

cerca de 300 picadas

Resolução. A resposta completa à adrenalina e o tempo de observação da anafilaxia fazem a alta com prescrição de adrenalina autoinjetável parecer a conduta completa. Mas há dois acidentes diferentes no mesmo paciente: a reação alérgica, que se resolveu, e o envenenamento tóxico por centenas de picadas, que é dose-dependente e tardio. Com mais de 100 a 200 picadas num adulto, a melitina e a fosfolipase A2 causam hemólise intravascular, rabdomiólise, lesão hepática e lesão renal aguda, que costumam surgir entre 12 e 72 horas depois, com urina ainda clara nas primeiras horas. Por isso a conduta é internar, hidratar e seguir CK, creatinina, potássio, hemograma, bilirrubinas e cor da urina por 48 a 72 horas. A IgE específica e a triptase servem ao diagnóstico da alergia e ao encaminhamento para imunoterapia, mas não protegem contra a toxicidade que ainda vai se manifestar.

A) Triptase sérica e alta após 6 horas

Errada. A triptase confirma anafilaxia retrospectivamente, e a alta em 6 horas ignora a toxicidade tardia das centenas de picadas.

B) Internação com CK e creatinina seriadas CORRETA

Correta. Envenenamento maciço exige internação e vigilância de hemólise, rabdomiólise e função renal, que se manifestam horas a dias depois.

C) IgE específica para veneno de abelha
Errada. A IgE específica orienta a imunoterapia depois, e é pouco confiável logo após a reação; não muda a conduta de agora.

D) Alta com adrenalina autoinjetável ARMADILHA
Errada. É a armadilha: seria a alta adequada após anafilaxia por poucas picadas; com 300 picadas, a toxicidade sistêmica ainda vai aparecer.

Para levar. No ataque por enxame, anafilaxia e envenenamento são acidentes distintos: com centenas de picadas, internar e seguir CK, creatinina e hemólise por 48 a 72 horas, mesmo com a alergia resolvida.

Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2023), acidentes por abelhas; Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos (MS/FUNASA).

---

15 Cardiologia · Megaesôfago com BRD e BDAS: a lesão esperada é o aneurisma apical chagásico, e não a obliteração apical da endomiocardiofibrose

Dado omitido **Gabarito D**

Homem de 54 anos, nascido no norte de Minas Gerais, onde viveu até os 20 anos, procura atendimento por palpitações e dispneia aos médios esforços há 6 meses. Há 15 anos tem dificuldade para engolir sólidos e líquidos, com regurgitação noturna, e perdeu 7 kg; esofagograma antigo mostrou esôfago dilatado com afilamento distal em 'bico de pássaro'. Nega etilismo e angina. Um exame de sangue de 3 anos atrás registrou 'eosinófilos 900/mm³', atribuídos a verminose e tratados com albendazol; o hemograma atual tem 280 eosinófilos/mm³. PA 112×70 mmHg, FC 58 bpm, irregular por extrassístoles; bulhas normofonéticas, sem sopros; sem estase jugular. ECG: bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo e extrassístoles ventriculares polimórficas. A alteração mais esperada no ecocardiograma é:

O DADO QUE DECIDE
esôfago dilatado com afilamento distal em 'bico de pássaro'

Resolução. O caso não nomeia a doença, e a eosinofilia antiga é colocada para puxar a endomiocardiofibrose, cuja marca no eco é a obliteração do ápice por fibrose e trombo: essa é a isca. O que decide é o conjunto de origem em área endêmica, megaesôfago (acalasia secundária à destruição dos plexos mioentéricos pelo Trypanosoma cruzi), bradicardia com extrassístoles ventriculares polimórficas e a dupla de bloqueio de ramo direito com divisional anterossuperior, que é a assinatura eletrocardiográfica da cardiopatia chagásica crônica. A lesão estrutural mais característica dessa cardiopatia é o aneurisma apical do VE (lesão vorticilar), muitas vezes com trombo, ao lado de hipocinesia inferolateral basal, e ela explica a arritmia ventricular e o risco embólico. A eosinofilia atual é normal e a antiga, tratada como verminose, não sustenta síndrome hipereosinofílica.

A) Hipertrofia septal assimétrica
Errada. Hipertrofia septal assimétrica é da cardiomiopatia hipertrófica, com sopro que aumenta na manobra de Valsalva e sobrecarga de VE no ECG, não com megaesôfago e bloqueio bifascicular.

B) Obliteração apical por fibrose endocárdica ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. Seria a lesão da endomiocardiofibrose ou da fase fibrótica de Löffler, com hipereosinofilia sustentada e fisiologia restritiva; aqui os eosinófilos atuais são normais e há megaesôfago.

C) Dilatação da raiz da aorta

Errada. Dilatação da raiz aórtica é a lesão do Marfan, da sífilis terciária e da valva bicúspide, sem relação com megaesôfago.

D) Aneurisma apical do ventrículo esquerdo CORRETA

Correta. Megaesôfago, área endêmica, bradicardia, extrassístoles polimórficas e BRD com BDAS são cardiopatia chagásica, cuja lesão característica é o aneurisma apical.

Para levar. Megaesôfago ou megacólon com BRD e BDAS é Chagas, e o eco esperado é aneurisma apical do VE (com trombo) e hipocinesia inferolateral; obliteração apical por fibrose é endomiocardiofibrose.

Diretriz da SBC sobre Diagnóstico e Tratamento de Pacientes com Cardiomiopatia da Doença de Chagas, 2023; II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, 2015; AHA Scientific Statement on Chagas cardiomyopathy, 2018

16

Endocrinologia · Hipercalcemia que persiste desde o terceiro mês após transplante renal bem-sucedido, com quatro paratireoides aumentadas: hiperparatireoidismo terciário

Cronologia **Gabarito A**

Homem de 46 anos, em hemodiálise por 9 anos por glomerulonefrite crônica, recebeu transplante renal de doador falecido há 14 meses, com boa função do enxerto (creatinina 1,2 mg/dL). Antes do transplante usava calcitriol, cinacalcete e sevelâmer, com PTH entre 1.100 e 1.500 pg/mL; os três foram suspensos no transplante. Usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia. Na revisão, assintomático: cálcio total 11,4 mg/dL (albumina 4,1 g/dL), fósforo 2,0 mg/dL, PTH 620 pg/mL, 25-hidroxivitamina D 32 ng/mL, fosfatase alcalina levemente elevada. O cálcio já estava em 10,9 mg/dL no terceiro mês e não normalizou desde então. Ultrassonografia cervical: quatro paratireoides aumentadas. A causa da hipercalcemia é:

O DADO QUE DECIDE

O cálcio já estava em 10,9 mg/dL no terceiro mês e não normalizou desde então

Resolução. O PTH caiu de cerca de 1.300 para 620 pg/mL, e isso sugere que o hiperparatireoidismo secundário está apenas regredindo, que é a armadilha. Mas o secundário cursa com cálcio normal ou baixo; PTH alto com hipercalcemia e hipofosfatemia, com enxerto funcionando, significa que as glândulas hiperplásicas passaram a secretar de forma autônoma, sem responder ao cálcio: é o terciário. A cronologia decide: a hipercalcemia surgiu nos primeiros meses, quando o rim novo voltou a produzir calcitriol e a eliminar fósforo, e persiste após 1 ano, quando a regressão espontânea já deveria ter ocorrido. Quatro glândulas aumentadas falam de hiperplasia difusa, e não de adenoma único; o calcitriol foi suspenso há mais de 1 ano. Hipercalcemia persistente após 1 ano do transplante é indicação de paratireoidectomia subtotal, pelo risco ao enxerto (nefrocalcinose) e ao osso.

A) Hiperparatireoidismo terciário persistente CORRETA

Correta. PTH alto com cálcio alto e fósforo baixo, persistindo mais de 1 ano após transplante com boa função: secreção autônoma das glândulas hiperplásicas.

B) Excesso de calcitriol exógeno

Errada. Hipercalcemia por calcitriol suprime o PTH, e a droga foi suspensa há 14 meses.

C) Adenoma de paratireoide primário
Errada. Adenoma primário aparece como glândula única; aqui as quatro estão aumentadas, depois de anos de estímulo urêmico.

D) Hiperparatireoidismo secundário em regressão ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o PTH está caindo, mas o secundário não eleva o cálcio; hipercalcemia com PTH alto 14 meses depois é terciário.

Para levar. Após transplante renal, hipercalcemia com PTH alto e fósforo baixo que persiste além de 1 ano é hiperparatireoidismo terciário; o secundário nunca dá cálcio alto.

KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for CKD-MBD; KDIGO 2009 (Care of Kidney Transplant Recipients).

17

Nefrologia · Gestante com nefropatia por IgA, PA e proteinúria subindo no terceiro trimestre · relação sFlt-1/PlGF para separar pré-eclâmpsia sobreposta, e não biópsia

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 32 anos, primigesta com 29 semanas, com nefropatia por IgA diagnosticada por biópsia há três anos, creatinina pré-gestacional de 1,1 mg/dL e proteinúria de 0,9 g/24 h; trocou a losartana por nifedipino antes de engravidar e usa AAS 150 mg/dia desde a 12ª semana. Na consulta de rotina: PA 146/94 mmHg (era 124/78 mmHg com 24 semanas), sem cefaleia, sem dor epigástrica, edema discreto. Exames: creatinina 1,2 mg/dL, relação proteína/creatinina urinária de 2,4 g/g (era 1,0 g/g no primeiro trimestre), sedimento com 8 hemácias por campo (semelhante aos anteriores), hemoglobina 11,2 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, AST 22 U/L, LDH 190 U/L. Ultrassonografia obstétrica com crescimento fetal no percentil 40. Para separar pré-eclâmpsia sobreposta de atividade da doença renal, o exame mais útil neste momento é:

O DADO QUE DECIDE
PA 146/94 mmHg (era 124/78 mmHg com 24 semanas)

Resolução. A nefropatia por IgA é real e a proteinúria subiu, o que puxa para atividade glomerular e para a biópsia. Mas, na gestante com doença renal crônica, proteinúria e creatinina já alteradas não servem para diagnosticar pré-eclâmpsia, e a elevação nova da PA depois da 20ª semana é exatamente o sinal que a pré-eclâmpsia sobreposta dá. O sedimento igual aos anteriores fala contra atividade nefrítica. A relação sFlt-1/PlGF (ou o PlGF isolado) reflete o desequilíbrio angiogênico placentário e não depende da doença renal: valor baixo praticamente exclui pré-eclâmpsia na semana seguinte, e valor alto a sustenta. A biópsia renal depois de 28 semanas tem risco maior de sangramento e raramente muda a conduta antes do parto.

A) Relação sFlt-1/PlGF sérica CORRETA
Correta. O marcador angiogênico separa pré-eclâmpsia sobreposta de piora da doença renal, porque não depende da proteinúria basal.

B) Biópsia renal percutânea ARMADILHA
Errada. Seria discutida antes de 28 semanas com sedimento nefrítico novo; com 29 semanas, sedimento estável e suspeita de pré-eclâmpsia, o risco não se justifica.

C) Proteinúria de 24 horas

Errada. Quantificar de novo a proteinúria não ajuda: ela já era alta antes da gestação e subiria nos dois diagnósticos.

D) Ácido úrico sérico

Errada. O ácido úrico sobe na pré-eclâmpsia, mas também na doença renal; tem baixo valor para separar as duas.

Para levar. Na gestante com doença renal crônica, proteinúria e creatinina não diagnosticam pré-eclâmpsia; a PA nova e os marcadores angiogênicos (sFlt-1/PlGF) é que separam.

ISSHP 2021 classification, diagnosis and management of hypertensive disorders of pregnancy; NICE NG133 (atualização 2023, testes baseados em PlGF); FEBRASGO, Protocolo de pré-eclâmpsia 2023.

18

Oncologia · Compressão medular metastática com paraplegia completa há mais de 48 horas e coluna estável: radioterapia, sem cirurgia descompressiva

Cronologia

Gabarito C

Homem de 66 anos, com adenocarcinoma de pulmão metastático para ossos e ECOG 1 até o mês passado, procura atendimento por paraplegia completa (força grau 0 nos membros inferiores), nível sensitivo em T8 e retenção urinária, instalados há 4 dias, depois de 3 semanas de dorsalgia. Ressonância de toda a coluna: metástase em T8 com compressão epidural, colapso de 30% do corpo vertebral sem retropulsão e coluna considerada estável; demais níveis sem compressão. Expectativa de vida estimada maior que 6 meses. Já recebeu dexametasona. A conduta mais adequada para a compressão é:

O DADO QUE DECIDE

instalados há 4 dias

Resolução. Compressão medular com déficit em paciente com boa expectativa de vida lembra o estudo que mostrou vantagem da descompressão cirúrgica seguida de radioterapia, e a cirurgia vira reflexo. Mas aquele benefício foi para quem ainda tinha função neurológica a salvar: o estudo excluiu pacientes paraplégicos há mais de 48 horas, e com paraplegia completa por mais de 24 a 48 horas a chance de recuperar a marcha com a cirurgia é desprezível. Com a coluna estável, não há indicação de estabilização, e a cirurgia acrescentaria só risco. O tratamento é radioterapia, para controle local e da dor, mantendo dexametasona, reabilitação e cuidados com bexiga e pele. Vertebroplastia trata dor de fratura sem compressão epidural, e deixar sem radioterapia abandona o controle do tumor.

A) Descompressão cirúrgica seguida de radioterapia ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o benefício da cirurgia vale para déficit recente; paraplegia completa há 4 dias, com coluna estável, não recupera com descompressão.

B) Vertebroplastia com cimento

Errada. Indicada para dor de fratura vertebral sem compressão epidural; aqui há compressão medular.

C) Radioterapia CORRETA

Correta. Paraplegia completa há mais de 48 horas e coluna estável: radioterapia para controle local e da dor, sem cirurgia.

D) Dexametasona e reabilitação, sem radioterapia
Errada. Abre mão do controle tumoral e da dor, que a radioterapia oferece mesmo sem recuperação neurológica.

Para levar. Compressão medular metastática: a cirurgia descompressiva só beneficia déficit recente (paraplegia há menos de 48 horas) ou coluna instável; paraplegia completa estabelecida com coluna estável vai para radioterapia.

NICE Guideline NG234: Spinal metastases and metastatic spinal cord compression (2023); Patchell RA et al., Lancet (2005)

19

Neurologia · Morte encefálica pela Resolução CFM 2.173/2017: a hora do óbito é a da conclusão do último procedimento, não a da assistolia

Cronologia **Gabarito C**

Homem de 58 anos, com hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva e herniação, cumpre todos os pré-requisitos e é submetido ao protocolo de morte encefálica: primeiro exame clínico concluído às 8h; teste de apneia concluído às 8h40, com PaCO2 final de 68 mmHg e nenhum movimento respiratório; segundo exame clínico, por outro médico capacitado, concluído às 10h; Doppler transcraniano com padrão de parada circulatória encefálica concluído às 13h. A família, informada de cada etapa, recusa a doação; o suporte é retirado e a assistolia ocorre às 16h. Pela Resolução CFM nº 2.173/2017, a hora a ser registrada como a da morte na declaração de óbito é:

O DADO QUE DECIDE

Doppler transcraniano com padrão de parada circulatória encefálica concluído às 13h

Resolução. A intuição leiga, e de muito médico, é que a morte acontece quando o coração para, e a assistolia das 16h é a armadilha. Pela resolução, a morte encefálica é a morte, e a declaração de óbito registra como data e hora aquelas da conclusão do último procedimento de determinação. Os procedimentos obrigatórios são três: dois exames clínicos por médicos diferentes, um teste de apneia e um exame complementar; aqui o último a terminar foi o Doppler transcraniano, às 13h. O teste de apneia positivo (PaCO2 acima de 55 mmHg sem incursões) e o segundo exame clínico não encerram o diagnóstico enquanto falta o exame complementar. A recusa da doação não muda a hora da morte: muda só o que se faz depois dela, e a retirada do suporte de um morto não é um novo óbito.

A) 8h40
Errada. O teste de apneia é um dos procedimentos, mas não o último; seria a hora da morte só se tivesse sido o último a ser concluído.

B) 10h
Errada. O segundo exame clínico fecha a parte clínica, mas o exame complementar ainda não tinha sido feito; seria a resposta se o Doppler tivesse sido feito antes dele.

C) 13h CORRETA
Correta. A hora da morte é a da conclusão do último procedimento de determinação, aqui o Doppler transcraniano.

D) 16h ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A assistolia após a retirada do suporte seria a hora do óbito num paciente sem morte encefálica, em que a morte é determinada por critério cardiorrespiratório.

Para levar. Na morte encefálica, a hora do óbito é a da conclusão do último procedimento obrigatório (dois exames clínicos, apneia e exame complementar), independentemente da doação e da assistolia posterior.

Resolução CFM nº 2.173/2017, art. 2º e art. 9º, e anexo I (Manual de Procedimentos para Determinação da Morte Encefálica).

20

Reumatologia · Artrite reativa pós-clamídia que passa de 6 meses apesar de dois AINEs: cronificou, e a conduta é DMARD (sulfassalazina)

Limiar **Gabarito B**

Homem de 34 anos teve uretrite por Chlamydia trachomatis há 9 meses, tratada com doxiciclina por 7 dias junto com a parceira, com teste de controle negativo. Duas semanas depois surgiu artrite de joelho direito e tornozelo esquerdo, com entesite no calcâneo. Usou naproxeno em dose plena e depois indometacina em dose plena, e recebeu duas infiltrações de corticoide no joelho, com melhora parcial e recidiva. Hoje mantém sinovite de joelho e tornozelo, sem dor lombar inflamatória, uveíte ou lesões de pele. HLA-B27 positivo, VHS 42 mm/h, PCR 22 mg/L, radiografias sem erosões; sorologias para HIV, hepatite B e hepatite C negativas. A conduta mais adequada é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *há 9 meses*

Resolução. Como a artrite começou com uma clamídia, a ideia de que o germe persiste e de que basta mais antibiótico atrai. Mas a uretrite foi tratada com teste de controle negativo, e antibiótico prolongado isolado não mudou a evolução da artrite reativa em ensaios. O dado que muda a conduta é o tempo: artrite reativa com mais de 6 meses é crônica, o que acontece em parte dos pacientes HLA-B27 positivos. Com falha de dois AINEs e infiltrações, o passo seguinte é DMARD convencional, e a sulfassalazina é o de maior evidência (metotrexato é alternativa). Anti-TNF fica para falha do DMARD; corticoide sistêmico em dose alta não tem papel na doença articular crônica.

A) Doxiciclina por 3 meses ARMADILHA

Errada. A infecção foi erradicada; antibiótico prolongado isolado não altera a artrite reativa crônica.

B) Sulfassalazina 2 a 3 g/dia CORRETA

Correta. Artrite reativa acima de 6 meses refratária a AINE e infiltração pede DMARD, e a sulfassalazina é a primeira escolha.

C) Prednisona 1 mg/kg/dia

Errada. Corticoide sistêmico em dose alta não é tratamento de manutenção da artrite periférica crônica.

D) Anti-TNF imediatamente

Errada. Fica para falha do DMARD convencional; pular o degrau é fazer mais do que o caso pede.

Para levar. Artrite reativa: AINE e infiltração nos primeiros meses; passou de 6 meses, é crônica e pede DMARD (sulfassalazina) antes do biológico.

Recomendações da SBR para o tratamento das espondiloartrites (2023); Schmitt SK. Reactive arthritis (Infect Dis Clin North Am, 2017).

---

21 Hematologia · Exantema após amoxicilina com eosinofilia, Coombs positivo e linfonodos que persistem: linfoma T angioimunoblástico, e não DRESS

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 68 anos é internado por febre, exantema maculopapular pruriginoso difuso e edema facial, iniciados 9 dias após amoxicilina para sinusite. Há 2 meses já referia sudorese noturna e perda de 6 kg. Exame: linfonodomegalias cervicais, axilares e inguinais de 2 a 3 cm, hepatoesplenomegalia e pequeno derrame pleural bilateral. Exames: Hb 9,4 g/dL, Coombs direto positivo, eosinófilos 1.600/mm³, plaquetas 140.000/mm³, LDH 620 U/L, gamaglobulina policlonal de 3,1 g/dL, AST, ALT e creatinina normais. Suspensa a amoxicilina e iniciada prednisona, o exantema melhorou em 1 semana, mas os linfonodos persistiam após 4 semanas. Biópsia excisional de linfonodo axilar: apagamento da arquitetura, proliferação de vênulas de endotélio alto, expansão da rede de células dendríticas foliculares, células T atípicas CD4+, PD-1+, CD10+ e CXCL13+, e imunoblastos B esparsos EBV positivos. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

Há 2 meses já referia sudorese noturna e perda de 6 kg

Resolução. Exantema com edema facial, eosinofilia, febre e linfonodomegalia 9 dias depois de um antibiótico é o retrato da DRESS, e o rótulo é verdadeiro: houve exposição e o exantema melhorou com corticoide. Mas os sintomas B começaram 2 meses antes da amoxicilina, a função hepática está normal, e os linfonodos não regrediram com a retirada da droga e o corticoide. Esse conjunto (exantema, sobretudo após antibiótico, linfonodomegalia generalizada, hipergamaglobulinemia policlonal, Coombs positivo, eosinofilia, derrames) é o modo de apresentação do linfoma T angioimunoblástico, linfoma de células T auxiliares foliculares do idoso. A biópsia confirma: vênulas de endotélio alto, rede de dendríticas foliculares expandida, células T com marcadores foliculares (PD-1, CXCL13, CD10) e imunoblastos B EBV positivos, que são passageiros, não a neoplasia. Castleman multicêntrica não tem células T clonais com fenótipo folicular, e no Hodgkin o EBV está nas células de Reed-Sternberg, CD30 e CD15 positivas.

A) DRESS pela amoxicilina ARMADILHA

Errada, é a armadilha. A DRESS explica o exantema e a eosinofilia, mas não sintomas B prévios à droga nem linfonodos que persistem semanas após suspendê-la e com corticoide.

B) Doença de Castleman multicêntrica

Errada. Castleman multicêntrica também tem hipergamaglobulinemia e vasos proeminentes, mas não células T atípicas com fenótipo folicular (PD-1, CXCL13).

C) Linfoma T angioimunoblástico CORRETA

Correta. Idoso com sintomas B, linfonodomegalia, Coombs positivo, hipergamaglobulinemia e biópsia com células T PD-1+ e CXCL13+: linfoma T angioimunoblástico.

D) Linfoma de Hodgkin clássico

Errada. No Hodgkin, as células neoplásicas são as de Reed-Sternberg, CD30 e CD15 positivas, não células T CD4+ foliculares.

Para levar. Linfonodomegalia generalizada com exantema após droga, Coombs positivo e hipergamaglobulinemia policlonal no idoso: se os linfonodos não regridem, biopsiar, porque o linfoma T angioimunoblástico imita DRESS.

Classificação OMS de neoplasias hematolinfoides, 5ª edição (2022); NCCN Guidelines T-cell Lymphomas (2025).

---

22 Infectologia · Endocardite aórtica estafilocócica com febre que volta e PR que se alarga durante o tratamento: abscesso perivalvar e cirurgia urgente

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 52 anos, sem valvopatia conhecida, está no 8º dia de oxacilina por endocardite de valva aórtica nativa por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. As hemoculturas negativaram no 3º dia e ele ficou afebril, mas há 2 dias voltou a ter febre de 38,3 °C. Não há flebite, o cateter periférico foi trocado, urina e radiografia de tórax normais; sem exantema e sem eosinofilia. ECG da admissão: ritmo sinusal, PR de 160 ms; ECG de hoje: ritmo sinusal, PR de 280 ms, sem outras alterações. PA 122 × 64 mmHg, sem sinais de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma transtorácico mostra a mesma vegetação de 8 mm e insuficiência aórtica leve. A complicação mais provável e a conduta, respectivamente, são:

O DADO QUE DECIDE

PR de 280 ms

Resolução. Febre que retorna depois de culturas negativas costuma ser atribuída à droga, ao cateter ou a outro foco, e quem reconhece o abscesso tende a tratá-lo com mais antibiótico. O dado que decide é o ECG: um bloqueio atrioventricular de primeiro grau novo na endocardite aórtica indica extensão perivalvar da infecção para a região do septo e do sistema de condução, porque o abscesso do anel aórtico fica junto ao nó atrioventricular e ao feixe de His. O ecocardiograma transtorácico tem sensibilidade baixa para abscesso, e o transesofágico deve confirmar, mas a decisão é cirúrgica: abscesso perivalvar é indicação de cirurgia urgente (em 3 a 5 dias, pela ESC 2023) pelo risco de bloqueio total, fístula e destruição do anel, e não se resolve com antibiótico. A febre por betalactâmico existe, mas vem com exantema ou eosinofilia e não alarga o PR.

A) Abscesso perivalvar / cirurgia urgente CORRETA
Correta. PR que se alarga na endocardite aórtica é extensão perivalvar até prova em contrário, e o abscesso é indicação de cirurgia urgente.

B) Abscesso perivalvar / ampliar o antibiótico ARMADILHA
Errada. É a armadilha: acerta a complicação, mas o abscesso perivalvar não se esteriliza com antibiótico e a cirurgia é a indicação.

C) Febre por betalactâmico / trocar por cefazolina
Errada. Seria a hipótese com exantema, eosinofilia e ECG inalterado; não explica o bloqueio atrioventricular novo.

D) Miocardite séptica / manter o esquema
Errada. Miocardite séptica daria disfunção ventricular e arritmias difusas; o alargamento isolado do PR na endocardite aórtica aponta o anel.

Para levar. Na endocardite aórtica, BAV novo ou PR que se alarga indica abscesso perivalvar, e isso é indicação de cirurgia urgente, não de ampliar antibiótico.

2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis; AHA Scientific Statement on infective endocarditis in adults (2015).

---

23 Pneumologia · Hipertensão arterial pulmonar idiopática: teste de vasorreatividade que cai 11 mmHg mas não chega a 40 é negativo

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 34 anos com hipertensão arterial pulmonar idiopática, classe funcional III, caminha 330 m no teste de 6 minutos; NT-proBNP 900 pg/mL. Cateterismo direito: pressão média da artéria pulmonar (PAPm) 52 mmHg, pressão de oclusão 9 mmHg, resistência vascular pulmonar 12 unidades Wood, débito cardíaco 3,6 L/min. No teste de vasorreatividade com óxido nítrico inalado, a PAPm cai para 41 mmHg, com débito cardíaco de 3,8 L/min. O resultado do teste e o tratamento inicial mais adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

a PAPm cai para 41 mmHg

Resolução. Uma queda de 11 mmHg parece resposta, e o aluno marca positivo com bloqueador de canal de cálcio. O critério de resposta exige as duas coisas: queda da PAPm de pelo menos 10 mmHg E valor absoluto final de 40 mmHg ou menos, com débito cardíaco mantido ou maior. Chegar a 41 mmHg falha o segundo critério, e o teste é negativo. Bloqueador de canal de cálcio em não respondedor piora a hemodinâmica e pode precipitar falência de ventrículo direito. Classe III, teste de caminhada entre 165 e 440 m e NT-proBNP entre 300 e 1.100 colocam a paciente em risco intermediário, para o qual a diretriz recomenda terapia combinada inicial com antagonista de endotelina e inibidor da fosfodiesterase 5.

A) Positivo / nifedipino em dose alta ARMADILHA
Errada. Exigiria PAPm final de 40 mmHg ou menos; com 41 o teste é negativo e o nifedipino é perigoso.

B) Positivo / ambrisentana e tadalafila
Errada. A combinação está certa para o risco intermediário, mas o teste não é positivo.

C) Negativo / nifedipino em dose alta
Errada. Se o teste é negativo, o bloqueador de canal de cálcio não tem indicação e pode causar colapso hemodinâmico.

D) Negativo / ambrisentana e tadalafila CORRETA
Correta. Queda de 11 mmHg sem atingir 40 mmHg é teste negativo; risco intermediário pede ambrisentana com tadalafila.

Para levar. Vasorreatividade positiva: PAPm cai 10 mmHg ou mais E chega a 40 mmHg ou menos, com débito mantido. Só os respondedores (menos de 10%) usam bloqueador de canal de cálcio.

ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension (2022); 7th World Symposium on Pulmonary Hypertension (2024).

---

24 Gastroenterologia · Dor pós-prandial com medo de comer e emagrecimento em diabética tabagista rotulada como gastroparesia: isquemia mesentérica crônica

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 68 anos, tabagista ativa de 50 anos-maço, hipertensa e com diabetes tipo 2 há 15 anos com retinopatia, refere há 6 meses dor abdominal periumbilical em cólica que começa 20 a 30 minutos após as refeições e dura 1 a 2 horas. Passou a comer pouco por medo da dor e perdeu 11 kg. Endoscopia e colonoscopia recentes normais; TC de abdome sem contraste sem massas. Cintilografia de esvaziamento gástrico com retenção de 18% em 4 horas (normal até 10%), e o quadro foi atribuído a gastroparesia diabética. Exame: abdome flácido e indolor, com sopro epigástrico; pulsos pediosos diminuídos. Lipase e enzimas hepáticas normais. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

começa 20 a 30 minutos após as refeições e dura 1 a 2 horas

Resolução. A cintilografia alterada em diabética de longa data é um rótulo verdadeiro: ela provavelmente tem algum grau de gastroparesia. Mas a gastroparesia dá náusea, plenitude e vômitos, não dor em cólica com hora marcada; o padrão de dor que começa 20 a 30 minutos após comer e dura 1 a 2 horas, com sitofobia (medo de comer) e grande emagrecimento, é a angina intestinal. O terreno vascular completa o quadro: tabagismo pesado, diabetes com microangiopatia, sopro epigástrico e pulsos periféricos diminuídos. A isquemia mesentérica crônica costuma exigir estenose de pelo menos dois dos três troncos (celíaco, mesentérica superior e inferior) e é diagnosticada por angiotomografia; o tratamento de escolha atual é a revascularização endovascular. Câncer de pâncreas e pancreatite crônica entram no diferencial do emagrecimento com dor, mas a TC sem massa, a lipase normal e o caráter pós-prandial estrito apontam para a isquemia.

A) Câncer de pâncreas oculto
Errada. Entra no diferencial de dor e emagrecimento, mas não explica a dor de hora marcada após cada refeição nem o sopro e a doença vascular difusa.

B) Gastroparesia diabética ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a cintilografia é verdadeira, mas gastroparesia causa náusea e plenitude, não dor em cólica pós-prandial com medo de comer.

C) Isquemia mesentérica crônica CORRETA
Correta. Angina intestinal com sitofobia e emagrecimento em paciente com aterosclerose difusa e sopro epigástrico.

D) Pancreatite crônica
Errada. Sem etilismo, sem esteatorreia e sem calcificações na TC; a dor não teria esse padrão estrito pós-prandial.

Para levar. Dor abdominal 20 a 30 minutos após comer, medo de comer e emagrecimento em paciente vascular: isquemia mesentérica crônica até prova em contrário; angiotomografia confirma.

ESVS 2017 Clinical Practice Guidelines on the Management of the Diseases of Mesenteric Arteries and Veins (Björck M et al., Eur J Vasc Endovasc Surg, 2017)

25 Cardiologia · Cardiomiopatia induzida por taquicardia na fibrilação atrial persistente: restaurar o ritmo e reavaliar a FE antes de indicar CDI

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 58 anos, sem doenças prévias, procura atendimento por palpitações e dispneia progressiva há 4 meses. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 140 bpm. Ecocardiograma: VE com diâmetro diastólico de 61 mm, FE 28%, hipocinesia difusa, átrio esquerdo de 46 mm. Cineangiocoronariografia sem lesões; ressonância sem realce tardio; TSH normal, sem etilismo. Está há 5 semanas em uso regular de apixabana, carvedilol em dose máxima tolerada, sacubitril-valsartana, espironolactona e dapagliflozina; a FC em repouso caiu para 112 bpm, mas no Holter a média de 24 horas é 118 bpm. Sem sinais de congestão hoje. O cardiologista do convênio sugere implantar logo um cardiodesfibrilador 'porque a FE está abaixo de 35%'. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Cineangiocoronariografia sem lesões; ressonância sem realce tardio

Resolução. FE abaixo de 35% lembra a indicação de CDI, que é a isca, mas a diretriz exige pelo menos 3 meses de tratamento otimizado e, quando há causa potencialmente reversível, a correção dela antes. FA persistente com resposta ventricular alta e mal controlada, coronárias normais e ressonância sem realce tardio (sem fibrose) é o cenário da cardiomiopatia induzida por taquicardia, que costuma recuperar a FE em semanas a meses depois de restaurado o ritmo sinusal. Com mais de 3 semanas de anticoagulação eficaz, a cardioversão elétrica pode ser feita sem eco transesofágico, mantendo a anticoagulação por pelo menos 4 semanas depois, e a ablação por cateter da FA (recomendação classe I quando se suspeita de cardiomiopatia induzida por taquicardia) é a via para manter o ritmo, sobretudo se houver recorrência. A FE é reavaliada após cerca de 3 meses: se recuperar, o diagnóstico se confirma e o CDI não é necessário.

A) Associar digoxina e manter o controle de frequência
Errada. A digoxina pode ajudar no controle de frequência, mas manter a FA quando a disfunção é provavelmente induzida pela taquicardia perde a chance de recuperar a FE.

B) Cardioversão elétrica e reavaliação da FE em 3 meses CORRETA
Correta. Com mais de 3 semanas de anticoagulação, restaurar o ritmo sinusal trata a causa provável da disfunção, e a FE reavaliada em 3 meses decide sobre dispositivos.

C) Ablação do nó atrioventricular com marca-passo
Errada. A ablação do nó com marca-passo é para FA permanente refratária ao controle de frequência e de ritmo; ainda não se tentou o ritmo sinusal.

D) Implante de cardiodesfibrilador para prevenção primária ARMADILHA
Errada, e é a armadilha. O CDI de prevenção primária exige FE de 35% ou menos após pelo menos 3 meses de tratamento otimizado e sem causa reversível; aqui a taquicardia persistente é a causa provável e ainda não foi corrigida.

Para levar. FE baixa com FA de resposta alta, coronárias normais e sem fibrose na ressonância: suspeite de cardiomiopatia induzida por taquicardia, restaure o ritmo e reavalie a FE em cerca de 3 meses antes de indicar CDI.

ESC 2024 Guidelines for the management of atrial fibrillation; ESC 2021 Guidelines for heart failure e atualização 2023; ESC 2022 Guidelines for ventricular arrhythmias (indicação de CDI)

26 Reumatologia · Parótidas aumentadas, uveíte granulomatosa e paralisia facial com contato de caxumba: febre uveoparotídea da sarcoidose

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Mulher de 29 anos procura atendimento por aumento bilateral das parótidas há 3 semanas, com febre baixa, olhos vermelhos e fotofobia há 10 dias e, desde ontem, dificuldade para fechar o olho esquerdo e desvio da boca para a direita. Mora com um sobrinho de 5 anos que teve caxumba há 1 mês, e não tem registro de vacinação. Exame físico: Tax 37,8 °C, parótidas aumentadas, firmes e pouco dolorosas, sem saída de pus pelo ducto; paralisia facial periférica à esquerda; injeção ciliar bilateral com precipitados ceráticos em gordura de carneiro. Exames: amilase 210 U/L, cálcio 10,9 mg/dL, linfócitos 900/mm³. Radiografia de tórax com alargamento hilar bilateral e simétrico. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

alargamento hilar bilateral e simétrico

Resolução. O contato com caxumba e a falta de vacinação são verdadeiros e parecem explicar a parotidite. Mas caxumba não dá uveíte granulomatosa (precipitados em gordura de carneiro), não dura 3 semanas com parótidas firmes e indolores, e não explica hipercalcemia, linfopenia e adenopatia hilar bilateral. A combinação de parotidite, uveíte anterior, paralisia facial e febre é a síndrome de Heerfordt (febre uveoparotídea), forma aguda da sarcoidose. A confirmação vem da biópsia do sítio mais acessível (glândula salivar, linfonodo por ecobroncoscopia) com granuloma não caseoso, e a paralisia facial com uveíte costuma pedir corticoide sistêmico.

A) Sarcoidose com febre uveoparotídea CORRETA
Correta. Parotidite, uveíte granulomatosa, paralisia facial e febre com adenopatia hilar e hipercalcemia.

B) Caxumba com neurite facial ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com parotidite dolorosa de poucos dias; não explica uveíte granulomatosa, hipercalcemia e adenopatia hilar.

C) Síndrome de Sjögren primária
Errada. Aumento de parótidas e olho seco, mas sem uveíte granulomatosa, paralisia facial e adenopatia hilar.

D) Linfoma não Hodgkin
Errada. Pode dar parótida e hilo aumentados, mas adenopatia hilar simétrica com uveíte granulomatosa é sarcoidose.

Para levar. Parotidite, uveíte, paralisia facial e febre com adenopatia hilar bilateral é a síndrome de Heerfordt, forma aguda da sarcoidose.

ATS Clinical Practice Guideline: Diagnosis and Detection of Sarcoidosis (2020); ERS clinical practice guidelines on treatment of sarcoidosis (2021).

27 Endocrinologia · Terapia hormonal da menopausa na obesa com hipertrigliceridemia e útero presente: estrogênio transdérmico associado a progestagênio

Grade X / Y **Gabarito C**

Mulher de 52 anos, com última menstruação há 16 meses, procura atendimento por fogachos intensos (cerca de 12 por dia), despertares noturnos e prejuízo no trabalho, sem melhora com medidas comportamentais. Tem útero e ovários. Tem enxaqueca sem aura, hipertensão controlada com losartana, IMC 33 kg/m² e triglicerídeos de 410 mg/dL; não tem antecedente de trombose, câncer de mama nem doença coronariana. Mamografia BI-RADS 1 há 4 meses e risco cardiovascular em 10 anos estimado em 6%. Ela deseja tratamento hormonal. Quanto à via do estrogênio e à associação com progestagênio, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Tem útero e ovários

Resolução. Ela está na janela de oportunidade (menos de 60 anos e menos de 10 anos de menopausa), tem sintomas vasomotores moderados a graves e nenhuma contraindicação absoluta, e a terapia hormonal é indicada. Duas decisões. A via: obesidade, hipertrigliceridemia, enxaqueca e hipertensão favorecem a via transdérmica, que evita a primeira passagem hepática e não eleva triglicerídeos nem o risco de trombose venosa como a oral. A associação: com útero presente, todo estrogênio sistêmico exige progestagênio para proteger o endométrio da hiperplasia e do câncer, qualquer que seja a via. A armadilha é achar que a via transdérmica, por ser mais segura, dispensa o progestagênio; a proteção endometrial depende do útero, não da via.

A) Oral / com progestagênio
Errada. O progestagênio está certo, mas o estrogênio oral eleva triglicerídeos (já em 410) e o risco trombótico na obesa.

B) Transdérmica / sem progestagênio ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a via está certa, mas mulher com útero precisa de progestagênio com qualquer estrogênio sistêmico.

C) Transdérmica / com progestagênio CORRETA
Correta. Via transdérmica pela hipertrigliceridemia, obesidade e enxaqueca, e progestagênio porque há útero.

D) Oral / sem progestagênio
Errada. Estrogênio oral isolado é a opção da histerectomizada sem fatores metabólicos; aqui erra as duas decisões.

Para levar. Terapia hormonal: útero presente pede progestagênio sempre; obesidade, hipertrigliceridemia, enxaqueca ou risco trombótico pedem estrogênio transdérmico.

The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society; Consenso Brasileiro de Terapêutica Hormonal da Menopausa (SOBRAC 2018).

28

Nefrologia · Contraste iodado intravenoso no paciente em hemodiálise anúrico · manter a sessão programada, sem diálise extra nem profilaxia

Omissão **Gabarito B**

Homem de 66 anos, em hemodiálise há quatro anos por doença renal do diabetes, anúrico, com sessões às segundas, quartas e sextas-feiras por fístula arteriovenosa e ganho de peso interdialítico habitual de 1,5 kg. Na terça-feira pela manhã faz tomografia de abdome com 100 mL de contraste iodado de baixa osmolalidade, para investigar dor lombar. Depois do exame está assintomático: PA 138/82 mmHg, FC 78 bpm, sem dispneia, SpO2 de 97% em ar ambiente, sem estertores; potássio de 5,1 mEq/L na véspera. Em relação ao contraste, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

anúrico

Resolução. O contraste é dialisável, e por isso parece lógico removê-lo logo, para proteger o rim. Só que o paciente é anúrico: não há função renal residual a proteger, e diálise imediata não previne nada. O que poderia pedir sessão extra seria volume grande de contraste com congestão ou disfunção cardíaca grave, e ele está sem dispneia, sem estertores e com volume de 100 mL. Por isso o manual do ACR recomenda não antecipar nem acrescentar sessão, mantendo a escala habitual. Hidratar um anúrico só acrescenta volume que ele não elimina.

A) Hidratação venosa com salina isotônica
Errada. A hidratação é profilaxia para quem tem TFG abaixo de 30 e não está em diálise; no anúrico só causa sobrecarga.

B) Manter a sessão de quarta, sem extras CORRETA
Correta. Anúrico, sem congestão e com volume de contraste usual: manter a próxima sessão programada.

C) Hemodiálise adicional logo após o exame ARMADILHA
Errada. É a isca de que dialisável deve ser dialisado; sem função residual e sem congestão, a sessão extra não tem benefício e tem os riscos do procedimento.

D) N-acetilcisteína oral por 48 horas
Errada. N-acetilcisteína não tem benefício comprovado na lesão por contraste e não faz sentido sem função renal a proteger.

Para levar. Em hemodiálise e anúrico, o contraste iodado não pede sessão extra nem profilaxia; só congestão ou volume muito grande de contraste mudam isso.

ACR Manual on Contrast Media 2024; ESUR Guidelines on Contrast Agents (2018).

29

Neurologia · Paraplegia ao despertar após endoprótese de aorta toracoabdominal, com vibração e posição preservadas: infarto da artéria espinal anterior

Negativo no meio **Gabarito B**

Homem de 70 anos está no 1º dia de pós-operatório de correção endovascular de aneurisma toracoabdominal, com cobertura extensa da aorta descendente; a PAM chegou a 55 mmHg por 20 minutos no intraoperatório. Ao despertar, refere que não mexe as pernas e não sente a sonda vesical. Exame: paraplegia flácida, patelares e

aquileus abolidos, nível sensitivo para dor e temperatura em T10, com sensibilidade vibratória e posição segmentar preservadas nos pés; membros superiores normais. Sem febre e sem dor dorsal; o cateter peridural foi retirado há 10 horas com coagulograma normal. RM de coluna torácica sem coleção e sem compressão; difusão inconclusiva pelo artefato da prótese. A causa mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

com sensibilidade vibratória e posição segmentar preservadas nos pés

Resolução. Paraplegia aguda com nível sensitivo e bexiga neurogênica sugere mielopatia transversa, e o reflexo de quem não lê o exame sensitivo por coluna é chamar de mielite. O dado que decide é a dissociação: dor e temperatura perdidas abaixo de T10, vibração e posição preservadas. A artéria espinal anterior irriga os dois terços anteriores da medula (cornos anteriores, tratos corticoespinais e espinotalâmicos) e poupa as colunas dorsais, nutridas pelas espinais posteriores. A cobertura extensa da aorta descendente (que pode ocluir a artéria radicular magna de Adamkiewicz) somada à hipotensão intraoperatória dá o mecanismo. A flacidez e a arreflexia são do choque medular, não de nervo periférico; a RM sem coleção afasta o hematoma. A conduta imediata é elevar a PAM e considerar drenagem liquórica.

A) Hematoma epidural pelo cateter peridural
Errada. Hematoma epidural daria dor dorsal e compressão na RM, e acometeria todas as modalidades sensitivas.

B) Infarto da artéria espinal anterior CORRETA
Correta. Perda de dor e temperatura com colunas dorsais preservadas, após cobertura aórtica extensa e hipotensão: território da espinal anterior.

C) Mielite transversa aguda ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Mielite transversa se instala em horas a dias, com líquor inflamatório, e costuma acometer todas as modalidades, inclusive vibração e posição.

D) Síndrome de Guillain-Barré
Errada. Guillain-Barré não dá nível sensitivo nem retenção urinária precoce, e é ascendente em dias.

Para levar. Paraplegia com perda de dor e temperatura e vibração preservada é infarto da artéria espinal anterior; após cirurgia da aorta, pense nele primeiro.

Rubin MN, Rabinstein AA. Vascular diseases of the spinal cord. Neurol Clin 2013; ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of aortic diseases 2024 (proteção medular na correção toracoabdominal).

30

Hematologia · Amiloidose AL cardíaca em estágio avançado: daratumumabe com ciclofosfamida, bortezomibe e dexametasona, sem transplante e sem tafamidis

Qualificador **Gabarito D**

Mulher de 63 anos, com dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores há 5 meses, macroglossia e púrpura periorbitária. Ecocardiograma: hipertrofia concêntrica de 15 mm, FE de 50%, strain longitudinal com preservação apical. ECG com baixa voltagem. NT-proBNP 6.200 pg/mL, troponina T 0,09 ng/mL, cadeias leves livres lambda 380 mg/L e kappa 11 mg/L. Aspirado de gordura abdominal com vermelho Congo positivo; tipagem por espectrometria de massa: cadeia leve lambda. Medula com 8% de plasmócitos clonais. Creatinina 1,1 mg/dL. PA 96 × 62 mmHg, FC 88 bpm. O tratamento inicial mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

tipagem por espectrometria de massa: cadeia leve lambda

Resolução. Cardiomiopatia infiltrativa com preservação apical do strain e baixa voltagem leva direto à amiloidose cardíaca, e o tafamidis, droga mais conhecida para ela, atrai. Mas o tafamidis estabiliza a transtirretina e só serve à amiloidose ATTR; aqui a tipagem mostrou cadeia leve lambda, com clone plasmocitário e razão de cadeias leves muito alterada: é amiloidose AL. O tratamento é dirigido ao clone, e o esquema inicial de escolha é daratumumabe com ciclofosfamida, bortezomibe e dexametasona (estudo ANDROMEDA), que produz respostas hematológicas mais rápidas e profundas, o que define a sobrevida no acometimento cardíaco. O autotransplante com melfalano em alta dose não é opção inicial aqui: NT-proBNP acima de 5.000 pg/mL, troponina T elevada e pressão sistólica baixa indicam estágio cardíaco avançado (Mayo IIIa, ainda abaixo do limiar de 8.500 do estágio IIIb), com mortalidade proibitiva no procedimento. O transplante cardíaco isolado, sem controle do clone, é seguido de deposição no enxerto.

A) Tafamidis 61 mg ao dia ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Tafamidis é para amiloidose por transtirretina; não age sobre cadeias leves.

B) Melfalano em alta dose com autotransplante
Errada. O autotransplante exige estágio cardíaco precoce; NT-proBNP acima de 5.000, troponina T acima de 0,06 e PA sistólica abaixo de 100 o contraindicam.

C) Transplante cardíaco isolado
Errada. Sem controle do clone, a amiloide se deposita no novo coração; só se discute em casos selecionados, após resposta hematológica.

D) Daratumumabe, ciclofosfamida, bortezomibe e dexametasona CORRETA
Correta. Amiloidose AL com acometimento cardíaco avançado: Dara-CyBorD como tratamento inicial, com dexametasona em dose ajustada.

Para levar. Amiloidose cardíaca se trata pelo tipo: AL (cadeia leve) com quimioimunoterapia dirigida ao clone (Dara-CyBorD); tafamidis é só para ATTR; NT-proBNP e troponina definem o estágio e afastam o autotransplante.

Kastritis E et al., ANDROMEDA (N Engl J Med 2021); Wechalekar AD et al., Guidelines for non-transplant chemotherapy for treatment of systemic AL amyloidosis: EHA-ISA working group (Amyloid 2023); Diretriz da SBC sobre Diagnóstico e Tratamento da Amiloidose Cardíaca (2021).

---

31 Infectologia · Doença inflamatória pélvica leve em usuária de DIU de cobre: tratamento ambulatorial sem retirar o dispositivo

Omissão | Gabarito A

Mulher de 27 anos, com DIU de cobre há 2 anos, procura a UBS com dor em baixo ventre há 4 dias, corrimento amarelado e febre de 37,9 °C. Tem parceiro fixo e um parceiro eventual recente. Exame: PA 118 × 74 mmHg, FC 92 bpm, abdome doloroso em hipogástrio, sem descompressão dolorosa; ao toque, dor à mobilização do colo e anexos dolorosos bilateralmente, sem massa palpável; fios do DIU visíveis. β-hCG negativo. Ultrassonografia transvaginal: DIU bem posicionado, sem abscesso tubo-ovariano e sem coleção. Tolera dieta oral e não tem vômitos. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sem abscesso tubo-ovariano e sem coleção

Resolução. O DIU é visto como corpo estranho mantenedor da infecção, e a retirada parece obrigatória. Mas o risco de doença inflamatória pélvica atribuível ao DIU concentra-se nas primeiras semanas após a inserção, e os ensaios mostram que retirar o dispositivo não acelera a cura da DIP leve a moderada; por isso o PCDT e o CDC recomendam manter o DIU e reavaliar em 72 horas, retirando-o apenas se não houver melhora. Sem abscesso tubo-ovariano, sem gravidez, sem sinais de peritonite e com tolerância oral, o tratamento é ambulatorial: ceftriaxona 500 mg IM dose única, doxiciclina 100 mg de 12/12 horas por 14 dias e metronidazol 500 mg de 12/12 horas por 14 dias, com tratamento das parcerias dos últimos 60 dias. Internação seria indicada por abscesso, gestação, intolerância oral ou falha ambulatorial.

A) Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, mantendo o DIU CORRETA
Correta. DIP leve, sem abscesso e com tolerância oral: esquema ambulatorial de 14 dias, mantendo o DIU e reavaliando em 72 horas.

B) Internação e antibiótico intravenoso
Errada. A internação é para abscesso tubo-ovariano, gestação, peritonite, intolerância oral ou falha do esquema oral.

C) Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, retirando o DIU ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a retirada imediata não melhora a evolução e deixa a paciente sem contracepção; só se retira se não houver melhora.

D) Retirada do DIU e reavaliação em 72 horas
Errada. Retirar sem tratar é inverter a conduta: o antibiótico é o tratamento, e a retirada só entra na falha.

Para levar. Na DIP leve a moderada em usuária de DIU, trata-se ambulatorialmente com o DIU no lugar e reavalia-se em 72 horas; retirar só se não houver melhora.

Ministério da Saúde, PCDT para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022); CDC Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines (2021).

32

Gastroenterologia · Diverticulite com abscesso pélvico de 6 cm: Hinchey II e drenagem percutânea associada ao antibiótico

Grade X / Y

Gabarito A

Homem de 58 anos tem dor em fossa ilíaca esquerda há 4 dias e febre de 38,4 °C. PA 128×78 mmHg, FC 98 bpm. Abdome com dor e defesa localizadas na fossa ilíaca esquerda, sem sinais de peritonite difusa. Leucócitos 16.800/mm³, PCR 190 mg/L. TC com contraste: espessamento do sigmoide com divertículos e coleção pélvica de 6 cm, com parede realçada, sem gás livre fora da coleção e sem líquido livre difuso. Nunca fez colonoscopia. A classificação de Hinchey e a conduta inicial são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

coleção pélvica de 6 cm

Resolução. Abscesso pélvico ou a distância do cólon é Hinchey II (o Ib é pericólico), e o paciente está estável e sem peritonite, o que leva muitos a manter só antibiótico. Mas o tamanho decide: abscessos pequenos, até cerca de 3 a 4 cm, costumam resolver com antibiótico; acima disso, como esta coleção de 6 cm, a

recomendação é drenagem percutânea guiada por imagem associada ao antibiótico, que evita a cirurgia de urgência na maioria dos casos. Sigmoidectomia de urgência fica para peritonite purulenta ou fecal (Hinchey III e IV), falha da drenagem ou abscesso inacessível. Depois de resolvido o episódio, a colonoscopia em 6 a 8 semanas é indicada após diverticulite complicada, para afastar neoplasia, e nunca na fase aguda.

A) Hinchey II / antibiótico e drenagem percutânea CORRETA
Correta. Abscesso pélvico é Hinchey II, e 6 cm pede drenagem percutânea além do antibiótico.

B) Hinchey Ib / antibiótico isolado
Errada. Hinchey Ib é abscesso pericólico; este é pélvico e grande demais para antibiótico isolado.

C) Hinchey III / sigmoidectomia de urgência
Errada. Hinchey III é peritonite purulenta generalizada; não há líquido livre difuso nem peritonite.

D) Hinchey II / antibiótico isolado ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a classificação está certa, mas abscesso de 6 cm raramente resolve só com antibiótico.

Para levar. Diverticulite com abscesso: até 3 a 4 cm, antibiótico; maior, drenagem percutânea; colonoscopia 6 a 8 semanas após diverticulite complicada.

ASCRS Clinical Practice Guidelines for the Management of Left-sided Colonic Diverticulitis (2020); WSES Guidelines for the management of acute left sided colonic diverticulitis (2020)

---

33 Dermatologia · Lesão melanocítica suspeita: biópsia excisional com margem estreita antes de qualquer ampliação ou estadiamento

Cronologia | Gabarito C

Homem de 52 anos, fototipo II, tem no dorso uma lesão pigmentada de 9 mm, assimétrica, de bordas irregulares, com três tons de castanho e preto, que mudou de tamanho nos últimos 6 meses. A dermatoscopia mostra rede atípica e véu azul-esbranquiçado. Não há linfonodos palpáveis. A lesão é inteiramente acessível, e o fechamento primário após retirada é simples. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE
o fechamento primário após retirada é simples

Resolução. A suspeita de melanoma é alta, e por isso o apressado já opera com margem de segurança. A margem definitiva depende da espessura de Breslow, que só a histologia dá: 0,5 a 1 cm para in situ, 1 cm até 1 mm, 1 a 2 cm entre 1 e 2 mm, 2 cm acima de 2 mm. Ampliar 2 cm antes de saber a espessura pode tratar demais e altera a drenagem linfática, prejudicando a biópsia do linfonodo sentinela. A ordem é biópsia excisional com margem clínica de 1 a 3 mm, de espessura total, orientada no eixo da drenagem; depois, com o Breslow e a ulceração, decidem-se ampliação e linfonodo sentinela. O shaving superficial pode cortar a base e impedir a medida da espessura, e o PET-CT não tem papel antes do diagnóstico nem no melanoma inicial.

A) Biópsia por shaving superficial
Errada. O shaving superficial pode seccionar a base e impedir medir o Breslow, que define todo o tratamento.

B) PET-CT antes da biópsia

Errada. Estadiamento por imagem só depois do diagnóstico, e em geral a partir do estádio III.

C) Biópsia excisional com margem de 1 a 3 mm CORRETA

Correta. Lesão acessível com fechamento simples: excisão com margem de 1 a 3 mm para obter o Breslow antes de definir a margem final.

D) Ampliação com margem de 2 cm ARMADILHA

Errada. Seria a margem para Breslow acima de 2 mm, decidida após a histologia; feita antes, pode tratar demais e atrapalhar o linfonodo sentinela.

Para levar. Lesão suspeita de melanoma: primeiro biópsia excisional com margem de 1 a 3 mm; a margem definitiva e o linfonodo sentinela dependem do Breslow.

NCCN Guidelines Melanoma: Cutaneous (2025); Sociedade Brasileira de Dermatologia/GBM, Consenso de melanoma cutâneo; AAD Guidelines of care for primary cutaneous melanoma (2019).

34

Reumatologia · Ativação macrofágica na doença de Still em uso de tocilizumabe: PCR e febre silenciadas pelo bloqueio da IL-6

Cronologia **Gabarito C**

Mulher de 27 anos tem doença de Still do adulto há 2 anos, controlada com tocilizumabe endovenoso a cada 4 semanas e prednisona 5 mg/dia; a última infusão foi há 12 dias. Há 3 semanas teve faringite e há 10 dias sente astenia intensa e dor abdominal, sem febre aferida e sem exantema. Exame físico: Tax 37,1 °C, FC 110 bpm, PA 100 × 62 mmHg, baço palpável a 3 cm do rebordo. Exames de 2 meses atrás e de hoje, respectivamente: leucócitos 7.800 e 3.100/mm³; plaquetas 260.000 e 96.000/mm³; ferritina 310 e 14.600 ng/mL; AST 28 e 240 U/L; triglicerídeos 140 e 420 mg/dL; fibrinogênio 290 e 120 mg/dL; PCR 0,3 e 0,8 mg/dL. A explicação mais provável para a PCR praticamente normal neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

controlada com tocilizumabe endovenoso a cada 4 semanas

Resolução. A sequência dos exames mostra ativação macrofágica: citopenias novas, ferritina que multiplica por 47, transaminases, triglicerídeos altos e fibrinogênio consumido, com esplenomegalia, depois de uma infecção que serviu de gatilho. A PCR normal e a ausência de febre parecem contradizer. A explicação está na droga em uso: a PCR é produzida pelo fígado sob estímulo da IL-6, e o tocilizumabe, bloqueando o receptor da IL-6, a mantém baixa e suprime a febre mesmo com inflamação grave. A disfunção hepática da ativação macrofágica é leve aqui (AST 240) e não abole a síntese de PCR. Em quem usa bloqueador de IL-6, monitore ferritina, contagens, fibrinogênio e transaminases, e não a PCR.

A) Doença de Still em remissão

Errada. Citopenias, ferritina de 14.600 e fibrinogênio consumido não são remissão.

B) Consumo da PCR pelos macrófagos ativados

Errada. A PCR não é consumida por macrófagos; o mecanismo que a mantém baixa é a falta de estímulo hepático.

C) Bloqueio da síntese hepática dependente de IL-6 CORRETA

Correta. O tocilizumabe bloqueia o receptor da IL-6, que comanda a síntese hepática da PCR, e silencia febre e PCR.

D) Insuficiência hepática pela ativação macrofágica ARMADILHA

Errada. Seria plausível com insuficiência hepática grave e coagulopatia; transaminase de 240 não abole a síntese de PCR.

Para levar. Em uso de bloqueador de IL-6, febre e PCR deixam de servir como marcadores: ativação macrofágica e infecção grave se reconhecem pela ferritina, contagens, fibrinogênio e transaminases.

EULAR/ACR recommendations for the diagnosis and management of Still's disease (Ann Rheum Dis, 2024); 2022 EULAR/ACR points to consider for the diagnosis and management of HLH/MAS (Ann Rheum Dis, 2023); bula do tocilizumabe (ANVISA).

35

Cardiologia · Cardiomiopatia dilatada na adulta jovem tratada de osteossarcoma na adolescência: cardiotoxicidade tardia por antraciclina, e não miocardite

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Mulher de 33 anos procura atendimento por dispneia progressiva há 3 meses, hoje aos pequenos esforços, com ortopneia. Teve síndrome gripal há 6 semanas e acredita que 'o vírus atacou o coração'. Aos 14 anos tratou um tumor ósseo maligno do fêmur com quimioterapia antes e depois da cirurgia, e está em remissão desde então. Teve um parto há 4 anos, sem intercorrências. Bebe duas doses por semana; nega drogas. PA 104×68 mmHg, FC 104 bpm, B3, estertores em bases, edema de tornozelos. ECG: taquicardia sinusal, sem áreas inativas. Ecocardiograma: VE com diâmetro diastólico de 63 mm, FE 30%, hipocinesia difusa. Troponina discretamente elevada e estável; sorologia para Chagas negativa; TSH normal. Ressonância cardíaca: dilatação biventricular, sem edema miocárdico em T2 e sem realce tardio. Coronárias normais na angiotomografia. A etiologia mais provável da cardiomiopatia é:

O DADO QUE DECIDE

sem edema miocárdico em T2 e sem realce tardio

Resolução. A síndrome gripal recente é verdadeira e cria o rótulo de miocardite viral, que é a isca. Mas a ressonância decide: miocardite aguda tem edema em T2 e realce tardio mesoepicárdico ou não isquêmico (critérios de Lake Louise), e aqui não há nenhum dos dois. O dado omitido está na história oncológica: tumor ósseo maligno de fêmur tratado aos 14 anos com quimioterapia antes e depois da cirurgia é osteossarcoma, cujo esquema padrão contém doxorrubicina em dose cumulativa alta. A antraciclina causa cardiomiopatia dilatada dose-dependente que pode surgir décadas depois, e o risco é maior quando a exposição ocorre na infância e adolescência; por isso sobreviventes precisam de ecocardiograma periódico por toda a vida. O parto há 4 anos está fora da janela da cardiomiopatia periparto, e duas doses semanais de álcool não causam cardiomiopatia.

A) Cardiomiopatia periparto

Errada. A cardiomiopatia periparto surge do último mês da gestação até 5 meses após o parto; o parto foi há 4 anos.

B) Cardiotoxicidade tardia por antraciclina CORRETA

Correta. Osteossarcoma tratado na adolescência implica doxorrubicina em dose cumulativa alta, e a cardiomiopatia dilatada tardia, sem edema nem realce na ressonância, é a apresentação esperada.

C) Cardiomiopatia alcoólica

Errada. A cardiomiopatia alcoólica exige consumo pesado e prolongado (em geral acima de 80 g por dia por anos); duas doses por semana não a explicam.

D) Miocardite viral aguda ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Seria a resposta com edema em T2 e realce tardio mesoepicárdico na ressonância; a gripe recente é verdadeira, mas a ressonância não mostra inflamação.

Para levar. Cardiomiopatia dilatada em sobrevivente de câncer da infância ou adolescência (osteossarcoma, linfoma, leucemia): pense em antraciclina, que causa disfunção tardia décadas depois; a ressonância sem edema e sem realce afasta miocardite.

ESC 2022 Guidelines on cardio-oncology; Diretriz Brasileira de Cardio-oncologia SBC 2020; Children's Oncology Group Long-Term Follow-Up Guidelines v6.0, 2023

36

Nefrologia · Antibiótico intravenoso domiciliar em quem vai precisar de fístula · cateter tunelizado de pequeno calibre em jugular, e não PICC

Qualificador **Gabarito D**

Mulher de 58 anos, destra, com doença renal policística autossômica dominante, TFGe de 17 mL/min/1,73 m² com queda de 4 mL/min por ano, já orientada para hemodiálise e com avaliação para fístula arteriovenosa marcada para o próximo mês. Internada por osteomielite vertebral por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, terá seis semanas de cefazolina intravenosa três vezes ao dia, com alta prevista para terminar o tratamento em casa. As veias dos antebraços estão pérvias à ultrassonografia. Para o tratamento domiciliar, preservando o futuro acesso para diálise, o acesso venoso mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

TFGe de 17 mL/min/1,73 m²

Resolução. O PICC é o acesso padrão para antibiótico domiciliar prolongado, e pôr no braço dominante parece poupar o braço da futura fístula. Mas em doença renal crônica de estágio 3b a 5 o PICC é desaconselhado em qualquer braço: ele lesa e trombosa as veias cefálica, basílica e subclávia, das quais dependem a fístula e o retorno venoso dela, e a fístula pode ser feita em qualquer dos braços se o não dominante não servir. A recomendação é cateter venoso central tunelizado de pequeno calibre na jugular interna. A subclávia é evitada porque a estenose dela inviabiliza fístula do mesmo lado, e acesso periférico trocado por seis semanas puncionaria repetidamente as veias que se quer preservar.

A) Cateter não tunelizado em subclávia

Errada. Cateter não tunelizado não serve para seis semanas em casa, e a subclávia é o sítio com mais estenose venosa central, que inviabiliza fístula ipsilateral.

B) PICC no braço direito, dominante ARMADILHA

Errada. É a isca de poupar só o braço não dominante; na DRC avançada o PICC é evitado em ambos os braços, porque as veias dos dois podem ser necessárias.

C) Acesso periférico trocado a cada 72 horas

Errada. Punções e flebites repetidas nos antebraços por seis semanas destroem as veias que se quer preservar.

D) Cateter tunelizado fino na jugular CORRETA

Correta. Cateter tunelizado de pequeno calibre na jugular interna preserva as veias dos membros superiores e a subclávia.

Para levar. Na DRC estágio 3b a 5, evite PICC e subclávia; se for preciso acesso central prolongado, prefira cateter tunelizado de pequeno calibre na jugular interna.

KDOQI Clinical Practice Guideline for Vascular Access: 2019 Update; Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters (MAGIC), 2015.

37

Endocrinologia · Neuropatia autonômica cardiovascular do diabetes: a perda da variação da frequência cardíaca na respiração vem antes da hipotensão ortostática

Qualificador **Gabarito D**

Na neuropatia autonômica cardiovascular do diabetes, a alteração que costuma surgir mais precocemente, ainda sem sintomas, é:

O DADO QUE DECIDE

mais precocemente, ainda sem sintomas

Resolução. Hipotensão ortostática é a manifestação mais lembrada da neuropatia autonômica, e por isso atrai, mas é tardia. A neuropatia diabética é dependente do comprimento da fibra, e o vago, o nervo autonômico mais longo, é lesado primeiro: a primeira alteração é a redução da variabilidade da frequência cardíaca, medida pela resposta à respiração profunda (relação expiração e inspiração), à manobra de Valsalva e à mudança postural. Com a perda vagal surge a taquicardia de repouso; só depois, com a lesão simpática, aparecem a resposta pressórica reduzida e a hipotensão ortostática, e a frequência fixa, que não varia com nada, marca a denervação quase completa. Por isso o rastreio com os testes de reflexos cardiovasculares se faz no assintomático: no tipo 2 ao diagnóstico e no tipo 1 após 5 anos de doença.

A) Hipotensão ortostática sintomática ARMADILHA

Errada. É a armadilha: hipotensão ortostática depende de lesão simpática eferente e aparece em fase avançada.

B) Frequência cardíaca fixa em repouso

Errada. A frequência fixa, sem resposta a estímulos, indica denervação cardíaca quase completa, que é tardia.

C) Resposta pressórica reduzida ao handgrip

Errada. A resposta pressórica ao exercício isométrico avalia a via simpática, comprometida depois da parassimpática.

D) Menor variação da FC na respiração profunda CORRETA

Correta. A lesão vagal vem primeiro, e a perda da variação da frequência cardíaca na respiração profunda é o achado mais precoce.

Para levar. Neuropatia autonômica cardiovascular: primeiro cai a variabilidade da frequência cardíaca (vago), depois vem a taquicardia de repouso e só por último a hipotensão ortostática (simpático).

ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seção 12; Pop-Busui e cols., Diabetic Neuropathy: ADA Position Statement (Diabetes Care 2017); Diretriz SBD 2024.

---

38 Hematologia · Linfocitose B monoclonal x LLC: o limiar de 5.000 linfócitos B clonais por mm³

Limiar **Gabarito A**

Na ausência de linfonodomegalias, organomegalias, citopenias e sintomas, a linfocitose B monoclonal com fenótipo de leucemia linfocítica crônica se distingue da LLC por uma contagem de linfócitos B clonais no sangue periférico abaixo de:

O DADO QUE DECIDE

linfócitos B clonais no sangue periférico

Resolução. O número que vem à cabeça para linfocitose é o limite de 4.000 linfócitos totais por mm³, usado para definir linfocitose absoluta no adulto, e quem o usa erra o critério. O que separa a linfocitose B monoclonal (LBM) da LLC não é a contagem de linfócitos totais, e sim a de linfócitos B clonais medida pela citometria de fluxo: abaixo de 5.000/mm³, sem linfonodomegalia, organomegalia, citopenia ou sintomas, é LBM; a partir de 5.000/mm³ é LLC. A LBM de contagem alta (acima de 500/mm³) progride para LLC que precisa de tratamento em cerca de 1% a 2% ao ano, e o seguimento é anual com hemograma, sem tratamento. Se houver linfonodomegalia com menos de 5.000 B clonais, o diagnóstico passa a ser linfoma linfocítico de pequenas células.

A) 5.000/mm³ CORRETA
Correta. Abaixo de 5.000 linfócitos B clonais por mm³ e sem outros achados é LBM; a partir disso, LLC.

B) 10.000/mm³
Errada. Número sem papel nos critérios atuais; LLC já se define a partir de 5.000 B clonais.

C) 4.000/mm³ ARMADILHA
Errada, é a armadilha. É o limite de linfocitose absoluta (linfócitos totais), não o critério de clonalidade da LLC.

D) 15.000/mm³
Errada. Não há critério nesse valor; a LLC se diagnostica bem abaixo dele.

Para levar. LLC exige 5.000 ou mais linfócitos B clonais por mm³; abaixo disso, sem linfonodo, víscera ou citopenia, é linfocitose B monoclonal, só acompanhada.

iwCLL guidelines (Hallek et al., Blood 2018); Classificação OMS de neoplasias hematolinfoides, 5ª edição (2022).

---

39 Neurologia · Diplopia no diabético rotulada de paralisia microvascular do III nervo: a adução preservada na convergência localiza no fascículo longitudinal medial

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Homem de 67 anos, diabético há 15 anos (HbA1c 8,9%), acorda com visão dupla horizontal ao olhar para a esquerda. Sem cefaleia e sem dor ocular. O clínico registra 'provável paralisia microvascular do III nervo direito' porque o olho direito não aduz no olhar conjugado para a esquerda. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose; ao olhar para a esquerda, o olho esquerdo abduz por completo com nistagmo; ao olhar para a direita, os dois olhos se movem normalmente. PA 170/94 mmHg. O achado que, se presente, localiza a lesão no fascículo longitudinal medial e afasta a lesão do III nervo é:

O DADO QUE DECIDE

o olho esquerdo abduz por completo com nistagmo

Resolução. Diabético, sem dor, com pupila normal e falha de adução: a regra da paralisia microvascular do III nervo que poupa a pupila parece encaixar, e a pupila reativa é a armadilha, porque não localiza nada. O que o caso mostra é falha de adução de um olho com nistagmo do olho que abduz, o desenho da oftalmoplegia internuclear direita (lesão no fascículo longitudinal medial direito, na ponte ou no mesencéfalo). O teste que separa as duas é a convergência: na oftalmoplegia internuclear o reto medial e o núcleo do III estão íntegros e são acionados pela via de convergência, que não passa pelo fascículo, então o olho aduz ao convergir; na paralisia do III, o reto medial está fraco em qualquer comando. Ptose e limitação da elevação são achados a favor do III nervo, não contra. Num idoso vascular hipertenso, a oftalmoplegia internuclear unilateral é quase sempre isquêmica e pede RM com difusão.

A) Ptose da pálpebra direita
Errada. Ptose apontaria o III nervo (levantador da pálpebra), o contrário do que a questão pede.

B) Limitação da elevação do olho direito
Errada. Limitação da elevação também é sinal de III nervo (reto superior e oblíquo inferior); não aparece na lesão do fascículo.

C) Pupila direita fotorreagente ARMADILHA
Errada, é a armadilha. Pupila poupada é argumento para causa microvascular do III, mas não localiza no fascículo nem afasta o III.

D) Adução direita na convergência CORRETA
Correta. Adução que falha no olhar conjugado e funciona na convergência só acontece com reto medial e núcleo do III íntegros, ou seja, lesão no fascículo longitudinal medial.

Para levar. Falha de adução com nistagmo do olho contralateral que abduz: teste a convergência; adução preservada ao convergir localiza no fascículo longitudinal medial e afasta o III nervo.

Frohman TC, Frohman EM. Internuclear ophthalmoplegia. Neurol Clin 2010 (revisão); Keane JR. Internuclear ophthalmoplegia: unusual causes in 114 of 410 patients. Arch Neurol 2005.

40 Infectologia · Hepatite B aguda sintomática no adulto: o antiviral entra pela coagulopatia ou encefalopatia, e não pela ALT

Limiar **Gabarito D**

Homem de 38 anos, previamente hígido, tem hepatite B aguda há 3 semanas (HBsAg e anti-HBc IgM reagentes, anti-HDV não reagente). Está ictérico, sem confusão mental e sem ascite, em seguimento ambulatorial. Exames de hoje: ALT 2.400 U/L, bilirrubina total 6 mg/dL, RNI 1,1, albumina 3,9 g/dL. Nesse paciente, o tratamento antiviral (tenofovir ou entecavir) passará a estar indicado se surgir:

O DADO QUE DECIDE

RNI 1,1

Resolução. ALT de 2.400 U/L impressiona e faz pensar que o grau de necrose indica tratar, e o HBeAg com carga viral alta lembra os critérios da hepatite B crônica. Na infecção aguda do adulto imunocompetente, porém, mais de 95% eliminam o vírus espontaneamente, e a ALT muito alta reflete a resposta imune que faz essa eliminação; HBeAg e HBV-DNA altos são esperados na fase aguda e não indicam nada. O antiviral é reservado à hepatite aguda grave, definida pela função hepática: coagulopatia (RNI acima de 1,5), encefalopatia, ou curso protraído com bilirrubina persistentemente acima de 3 mg/dL por mais de 4 semanas, além da insuficiência hepática aguda, quando o paciente deve ser também encaminhado a centro de transplante. Hoje, com RNI de 1,1 e sem encefalopatia, a conduta é acompanhar com HBsAg em 6 meses para documentar a resolução.

A) HBeAg reagente com HBV-DNA alto
Errada. HBeAg e HBV-DNA altos são próprios da fase aguda e não definem tratamento; esse é raciocínio da hepatite B crônica.

B) ALT acima de 1.000 U/L por 4 semanas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a ALT mede a necrose e a resposta imune, não a gravidade funcional, e não é critério para antiviral na forma aguda.

C) Icterícia que dure mais de 2 semanas
Errada. A icterícia é comum na hepatite aguda; o curso protraído que indica antiviral é bilirrubina acima de 3 mg/dL por mais de 4 semanas, e não 2 semanas de icterícia.

D) RNI acima de 1,5 ou encefalopatia CORRETA
Correta. Coagulopatia ou encefalopatia definem hepatite B aguda grave, indicação de antiviral e de avaliação para transplante.

Para levar. Na hepatite B aguda do adulto, o antiviral é indicado pela gravidade funcional (RNI acima de 1,5, encefalopatia ou curso protraído), e não pela ALT nem pelo HBeAg.

AASLD Guidance on Prevention, Diagnosis and Treatment of Chronic Hepatitis B (2018); EASL Clinical Practice Guidelines on hepatitis B (2025); Ministério da Saúde, PCDT Hepatite B e Coinfecções (2023).

41 Oncologia · Metástase hepática de câncer de mama com HER2 2+ na imuno-histoquímica: hibridização in situ antes de decidir terapia anti-HER2

Rótulo verdadeiro **Gabarito D**

Mulher de 56 anos tratou há 5 anos carcinoma ductal invasivo de mama com receptor de estrogênio positivo e HER2 1+, seguido de 5 anos de hormonioterapia. Agora apresenta metástases hepáticas múltiplas, sem crise visceral, com bilirrubina e enzimas normais. Biópsia hepática: carcinoma de origem mamária, receptor de estrogênio positivo em 80%, receptor de progesterona negativo e HER2 escore 2+ na imuno-histoquímica. A equipe cogita trastuzumabe, pertuzumabe e taxano por considerar o tumor HER2 positivo. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

HER2 escore 2+ na imuno-histoquímica

Resolução. O escore 2+ soa como positivo, e a equipe já planeja o duplo bloqueio anti-HER2. Mas na imuno-histoquímica só o escore 3+ é positivo; o 2+ é equívoco e exige hibridização in situ (FISH ou outra técnica) para mostrar se há amplificação do gene. Se houver, o tumor é HER2 positivo e a primeira linha é o duplo bloqueio com taxano; se não houver, o tumor é HER2 baixo, que na primeira linha segue como luminal (hormonioterapia com inibidor de CDK4/6) e mais adiante pode receber trastuzumabe deruxtecana. A metástase deve ser biopsiada justamente porque o status pode mudar em relação ao primário, por isso repetir o primário não resolve. Painel de 21 genes é ferramenta de decisão adjuvante, e a pesquisa de PIK3CA entra depois da progressão à primeira linha hormonal.

A) Painel genômico de 21 genes
Errada. O painel de 21 genes orienta quimioterapia adjuvante na doença inicial, não a doença metastática.

B) Pesquisa de mutação de PIK3CA
Errada. É útil após progressão à hormonioterapia de primeira linha; não resolve o status HER2.

C) Nova imuno-histoquímica no tumor primário ARMADILHA
Errada. É a armadilha: o status da metástase é o que vale, porque pode divergir do primário; repetir o primário não define o tratamento atual.

D) Hibridização in situ para HER2 CORRETA
Correta. HER2 2+ é equívoco; a hibridização in situ define amplificação e, portanto, a terapia.

Para levar. HER2 na imuno-histoquímica: 3+ positivo, 0 e 1+ negativos, 2+ equívoco e obriga hibridização in situ.

ASCO/CAP Guideline Update: HER2 testing in breast cancer (2023); ESMO Metastatic Breast Cancer Living Guideline (2024)

---

42 Pneumologia · Pneumonia aspirativa sem abscesso nem empiema: esquema padrão de PAC, sem cobertura anaeróbica adicional

Omissão **Gabarito C**

Homem de 76 anos, com sequela de AVC e disfagia para líquidos documentada, tem febre há 2 dias, tosse e dispneia, iniciadas após um engasgo durante o almoço. FR 24 irpm, PA 128/76 mmHg, SpO2 91% em ar ambiente, nível de consciência igual ao habitual; ureia 38 mg/dL. Radiografia: consolidação no segmento posterior do lobo inferior direito, sem cavitação, sem nível hidroaéreo e sem derrame. Não recebeu antibiótico

nem foi internado nos últimos 90 dias; não é etilista, e a dentição está em bom estado. Internado em enfermaria, o esquema antimicrobiano mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

sem cavitação, sem nível hidroaéreo e sem derrame

Resolução. Engasgo, disfagia e lobo inferior direito fazem pensar em anaeróbio, e acrescentar metronidazol parece prudente. A microbiologia da pneumonia aspirativa adquirida na comunidade, porém, é a mesma da PAC (pneumococo, Haemophilus, Staphylococcus aureus, enterobactérias); anaeróbios só têm papel relevante quando há abscesso, empiema ou doença periodontal grave. A diretriz ATS/IDSA recomenda não acrescentar cobertura anaeróbica de rotina, o que poupa toxicidade e risco de Clostridioides difficile. Sem fatores de risco para MRSA ou Pseudomonas (sem antibiótico nem internação nos 90 dias), o esquema de enfermaria é betalactâmico com macrolídeo. Piperacilina-tazobactam seria escalonar sem indicação.

A) Clindamicina isolada
Errada. Cobre anaeróbios e Gram-positivos, mas falha em Haemophilus e atípicos, e tem alto risco de colite por C. difficile.

B) Ceftriaxona e metronidazol ARMADILHA
Errada. O metronidazol seria acrescentado com abscesso, empiema ou cavitação; nada disso existe aqui.

C) Ceftriaxona e azitromicina CORRETA
Correta. Pneumonia aspirativa sem abscesso nem empiema trata-se como PAC de enfermaria, sem cobertura anaeróbica extra.

D) Piperacilina-tazobactam
Errada. Seria opção com fator de risco para Pseudomonas ou pneumonia hospitalar; aqui é espectro desnecessário.

Para levar. Pneumonia aspirativa da comunidade sem abscesso ou empiema: o mesmo esquema da PAC, sem acrescentar anaerobicida.

ATS/IDSA Guideline for Community-acquired Pneumonia in Adults (2019); Mandell LA, Niederman MS, NEJM 2019 (Aspiration pneumonia).

43

Reumatologia · Síndrome nefrótica no lúpus com complemento normal, anti-DNA negativo e sedimento inativo: nefrite lúpica membranosa (classe V)

Negativo no meio

Gabarito D

Mulher de 36 anos tem lúpus eritematoso sistêmico há 6 anos, com manifestações cutâneas e articulares controladas com hidroxicloroquina. Há 2 meses tem edema de membros inferiores progressivo e urina espumosa, sem hematúria macroscópica, artrite ou exantema. Não usa anti-inflamatórios. PA 128 × 80 mmHg. Exames: albumina 2,1 g/dL, colesterol total 340 mg/dL, proteinúria de 6,2 g/24 h, creatinina 0,8 mg/dL, sedimento com 2 hemácias por campo e sem cilindros celulares, C3 e C4 normais, anti-DNA não reagente, anti-Sm reagente. A biópsia renal foi indicada. A classe histológica mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

C3 e C4 normais, anti-DNA não reagente

Resolução. Proteinúria nefrótica no lúpus faz pensar na classe IV, a mais frequente e a mais grave, e por isso ela atrai. Mas a classe IV vem com sedimento ativo (hematúria dismórfica, cilindros), hipertensão, queda da função renal, complemento consumido e anti-DNA em título alto. Síndrome nefrótica pura, com sedimento inativo, função preservada e sorologia quieta (C3 e C4 normais, anti-DNA negativo) é o perfil da classe V, membranosa, que pode surgir com a doença extrarrenal controlada. Ela merece atenção para trombose (sobretudo de veia renal) quando a albumina está muito baixa, e trata-se com bloqueio do eixo renina-angiotensina e imunossupressão (micofenolato com glicocorticoide, ou inibidor de calcineurina) quando a proteinúria é nefrótica.

A) II, mesangial
Errada. Classe II dá hematúria ou proteinúria discretas, raramente nefrótica.

B) III, focal
Errada. Classe proliferativa focal: sedimento ativo e sorologia em atividade, que faltam aqui.

C) IV, difusa ARMADILHA
Errada. Seria a resposta com sedimento ativo, complemento baixo, anti-DNA alto e piora da função renal.

D) V, membranosa CORRETA
Correta. Síndrome nefrótica com sedimento e sorologia inativos é o perfil da nefrite membranosa.

Para levar. No lúpus, síndrome nefrótica pura com complemento normal e anti-DNA negativo sugere classe V (membranosa); sedimento ativo e sorologia em atividade sugerem classes III e IV.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis; EULAR/ERA-EDTA recommendations for lupus nephritis (2019).

44

Cardiologia · Hipertensa crônica que planeja gestar: AAS a partir de 12 semanas e metildopa no lugar do IECA

Grade X / Y

Gabarito A

Mulher de 34 anos, hipertensa crônica controlada com enalapril e clortalidona, sem lesão de órgão-alvo, quer engravidar nos próximos meses. Para prevenção de pré-eclâmpsia e controle pressórico na gestação, a medida indicada e o anti-hipertensivo adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

hipertensa crônica controlada com enalapril

Resolução. Hipertensão crônica é fator de alto risco para pré-eclâmpsia, e o AAS em dose baixa (100 a 150 mg à noite) reduz esse risco quando começa entre 12 e 16 semanas, idealmente antes da 16ª, e segue até 36 semanas. Iniciar após 20 semanas é a isca: nessa fase a placentação já se completou e o benefício praticamente desaparece. O enalapril (e qualquer IECA ou BRA) deve ser trocado antes da concepção ou assim que a gestação for confirmada, pelo risco de fetopatia renal e oligoâmnio; metildopa, nifedipino de liberação prolongada e labetalol são as opções. Heparina profilática não previne pré-eclâmpsia.

A) AAS a partir de 12 semanas / metildopa CORRETA
Correta. AAS em dose baixa a partir de 12 semanas (até 16 para o benefício pleno) e troca do IECA por metildopa (ou nifedipino) é o preparo da hipertensa crônica.

B) AAS a partir de 20 semanas / metildopa ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. A metildopa está certa, mas o AAS iniciado após 20 semanas chega depois da placentação e perde o efeito preventivo.

C) Heparina profilática / metildopa

Errada. A heparina profilática não previne pré-eclâmpsia em hipertensa sem trombofilia ou síndrome antifosfolípide; a metildopa está certa.

D) AAS a partir de 20 semanas / losartana

Errada nas duas metades: AAS tardio e losartana, que, como o IECA, é contraindicada na gestação.

Para levar. Hipertensa crônica gestante: AAS 100 a 150 mg a partir de 12 semanas (antes de 16) e troca de IECA ou BRA por metildopa, nifedipino ou labetalol.

Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial 2025 (SBC/SBH/SBN); Protocolo FEBRASGO de pré-eclâmpsia 2023; ACOG Practice Bulletin 203 (Chronic Hypertension in Pregnancy) e Committee Opinion 743 (low-dose aspirin)

---

45 Hematologia · Necrose digital com sinais de hiperviscosidade, pico IgM monoclonal, C4 normal e fator reumatoide negativo: crioglobulinemia tipo I

Negativo no meio | Gabarito B

Homem de 71 anos procura atendimento por dor e cianose nas pontas dos dedos das mãos e nas orelhas, com piora no frio, há 1 mês, e necrose em duas polpas digitais. Refere episódios de turvação visual e cefaleia. Exame: livedo reticular nas coxas, necrose de duas polpas digitais com pulsos periféricos presentes; fundo de olho com veias tortuosas e dilatadas em salsicha. Exames: Hb 11,1 g/dL, reticulócitos, LDH e bilirrubinas normais, Coombs direto negativo, creatinina 1,0 mg/dL, urina sem hematúria, VHS 110 mm/h, C3 e C4 normais, fator reumatoide negativo, anti-HCV e HBsAg negativos, FAN e ANCA negativos. Eletroforese de proteínas com pico monoclonal de 3,2 g/dL, IgM kappa. Crioprecipitado presente no soro, com criócrito de 9%. A etiologia mais provável das lesões cutâneas é:

O DADO QUE DECIDE

C3 e C4 normais, fator reumatoide negativo

Resolução. IgM kappa monoclonal com acrocianose ao frio é também o perfil da doença das aglutininas frias, e o reflexo é pensar nela. Mas a doença das aglutininas frias é hemolítica: teria reticulocitose, LDH e bilirrubina elevadas e Coombs positivo para C3d, e aqui estão normais. A crioglobulinemia mista (tipo II, geralmente pelo HCV) é vasculite por imunocomplexo, com fator reumatoide positivo (a IgM monoclonal tem atividade de FR) e consumo de C4, além de púrpura e glomerulonefrite; os negativos do meio do caso afastam essa via. O que sobra é a crioglobulinemia tipo I: imunoglobulina monoclonal isolada que precipita no frio e oclui pequenos vasos, causando necrose acral, livedo e hiperviscosidade (veias retinianas em salsicha), associada a Waldenström, mieloma ou gamopatia monoclonal. O tratamento é dirigido ao clone, com plasmaférese nos casos graves, e não antiviral.

A) Crioglobulinemia mista pela hepatite C

Errada. A forma mista tem FR positivo, C4 consumido e, em geral, HCV; aqui os três estão ausentes.

B) Crioglobulinemia tipo I por gamopatia IgM CORRETA

Correta. IgM monoclonal crioprecipitável com necrose acral, hiperviscosidade, complemento normal e FR negativo: crioglobulinemia tipo I.

C) Doença das aglutininas frias ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Daria hemólise (LDH, bilirrubina, reticulócitos) e Coombs C3d positivo; não há hemólise.

D) Embolia de colesterol

Errada. Ateroembolismo ocorre após cateterismo ou anticoagulação, com eosinofilia e lesão renal, e não explica a crioglobulina.

Para levar. Crioglobulina com gamopatia monoclonal, sem FR, sem consumo de C4 e sem HCV é tipo I: oclusão e hiperviscosidade, não vasculite, e se trata o clone.

Muchtar E et al., How I treat cryoglobulinemia (Blood 2017); Terrier B et al., French Cryoglobulinemia Study Group (Blood 2013).

---

46 Gastroenterologia · Pseudo-obstrução colônica aguda refratária ao suporte em paciente com bradicardia: descompressão colonoscópica, e não neostigmina

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 74 anos, no 4º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, evolui com distensão abdominal progressiva, pouca dor e eliminação escassa de flatos. A oxicodona foi suspensa no início da distensão. Há 48 horas está em jejum, com sonda nasogástrica e sonda retal, deambulação estimulada e correção de potássio e magnésio, hoje normais; a distensão aumentou. Tem bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz I conhecido; FC 48 bpm, PA 128×70 mmHg. Abdome timpânico, sem defesa e sem descompressão dolorosa. Lactato e leucócitos normais. TC: dilatação de ceco (12,5 cm), cólon ascendente e transverso, sem ponto de transição mecânico, sem pneumatose e sem pneumoperitônio. A conduta mais adequada para este paciente é:

O DADO QUE DECIDE

FC 48 bpm

Resolução. Pseudo-obstrução colônica aguda (síndrome de Ogilvie) que não responde a 24 a 48 horas de suporte, com ceco acima de 12 cm, tem indicação de tratamento ativo, e o primeiro passo farmacológico é a neostigmina, por isso ela atrai. Mas a neostigmina, inibidor da acetilcolinesterase, provoca bradicardia, às vezes grave, e está contraindicada ou exige extrema cautela em quem já tem bradicardia, distúrbio de condução, broncoespasmo ou insuficiência renal grave. Com FC de 48 bpm e bloqueio atrioventricular, a alternativa para este paciente é a descompressão colonoscópica, com colocação de sonda descompressiva. Prolongar o suporte com ceco de 12,5 cm em aumento expõe a isquemia e perfuração, e a cirurgia fica para perfuração, isquemia ou falha das medidas não cirúrgicas.

A) Neostigmina intravenosa com monitorização ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a conduta padrão após falha do suporte, mas a bradicardia com bloqueio atrioventricular a contraindica.

B) Manter o suporte por mais 72 horas

Errada. O ceco de 12,5 cm em aumento após 48 horas de suporte já pede descompressão; esperar aumenta o risco de perfuração.

C) Colectomia direita de urgência
Errada. Cirurgia é para perfuração, isquemia ou falha da descompressão; não há pneumatose, pneumoperitônio nem peritonite.

D) Descompressão colonoscópica CORRETA
Correta. Falha do suporte com ceco acima de 12 cm e contraindicação à neostigmina: descompressão colonoscópica.

Para levar. Ogilvie refratário ao suporte: neostigmina é a primeira escolha, exceto com bradicardia, distúrbio de condução ou broncoespasmo; nesses, descompressão colonoscópica.

ASGE Guideline on the role of endoscopy in the management of acute colonic pseudo-obstruction and colonic volvulus (2020); ASCRS Clinical Practice Guidelines for Colonic Volvulus and Acute Colonic Pseudo-Obstruction (2021)

47

Endocrinologia · Insuficiência adrenal sob mitotano adjuvante com cortisol total normal: aumento da CBG e depuração acelerada da hidrocortisona

Rótulo verdadeiro

Gabarito D

Mulher de 43 anos foi submetida, há 5 meses, a adrenalectomia direita aberta por carcinoma adrenocortical de 11 cm secretor de cortisol, com Ki-67 de 18%. Iniciou mitotano adjuvante há 3 meses (nível sérico atual de 16 mg/L, alvo de 14 a 20) e usa hidrocortisona 20 mg/dia desde a cirurgia. Há 4 semanas tem astenia intensa, náuseas, anorexia e tontura ao levantar. PA 92 × 58 mmHg deitada e 78 × 50 mmHg em pé. Sódio 131 mEq/L, potássio 4,8 mEq/L, glicemia 74 mg/dL. Cortisol sérico total às 8 horas, 2 horas após a hidrocortisona: 21 µg/dL (referência 5 a 25). TSH 2,1 mUI/L, T4 livre 0,8 ng/dL (referência 0,9 a 1,8). Tomografia sem recidiva. O mecanismo que melhor explica o quadro é:

O DADO QUE DECIDE

Cortisol sérico total às 8 horas

Resolução. Cortisol de 21 µg/dL dentro da referência parece afastar insuficiência adrenal, e o T4 livre baixo, verdadeiro, oferece outra explicação: são os dois rótulos que desviam. O quadro (astenia, náuseas, hipotensão postural, hiponatremia, glicemia limítrofe) é de insuficiência adrenal sob reposição. O mitotano é adrenolítico e, além disso, aumenta a globulina ligadora de cortisol (CBG), elevando o cortisol total enquanto o livre, que é o ativo, fica baixo; e induz o CYP3A4, acelerando a depuração da hidrocortisona. Por isso quem usa mitotano precisa de 2 a 3 vezes a dose habitual de hidrocortisona (40 a 60 mg/dia), ajustada pela clínica, e não pelo cortisol total. O mitotano também reduz o T4 livre, mas hipotireoidismo leve não explica hipotensão, hiponatremia e hipoglicemia.

A) Recidiva tumoral com hipercortisolismo
Errada. Recidiva secretora daria hipertensão, hiperglicemia e fenótipo de Cushing, e a tomografia não mostra recidiva.

B) Neurotoxicidade por nível alto de mitotano
Errada. Neurotoxicidade (ataxia, confusão) aparece com nível acima de 20 mg/L; o nível está na faixa terapêutica.

C) Hipotireoidismo central causado pelo mitotano ARMADILHA

Errada. É a armadilha: o mitotano baixa o T4 livre, mas isso não explica hipotensão postural, hiponatremia e glicemia baixa.

D) Mais CBG e depuração acelerada da hidrocortisona CORRETA

Correta. O mitotano eleva a CBG (cortisol total falsamente tranquilizador) e induz o metabolismo da hidrocortisona, deixando o cortisol livre insuficiente.

Para levar. Em uso de mitotano, cortisol total não mede a reposição: a CBG sobe e a hidrocortisona é depurada mais rápido, e a dose costuma ser 2 a 3 vezes a habitual.

ESE/ENSAT 2018 (Management of adrenocortical carcinoma in adults); Endocrine Society 2016 (Primary Adrenal Insufficiency).

48

Neurologia · Hemorragia intracerebral com última dose de rivaroxabana há 60 horas e anti-Xa indetectável: nenhum agente reversor

Omissão

Gabarito A

Mulher de 74 anos, com fibrilação atrial em uso de rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, tomou a última dose há 60 horas, antes de suspender todos os remédios por gastroenterite com vômitos. É trazida por cefaleia e hemiparesia direita leve iniciadas há 3 horas. PA 168/92 mmHg, Glasgow 15. TC: hematoma lobar parietal esquerdo de 14 mL, sem extensão ventricular. Creatinina 0,9 mg/dL (clearance estimado de 62 mL/min), RNI 1,1, TTPa normal, plaquetas 230.000/mm³; atividade anti-Xa calibrada para rivaroxabana abaixo do limite de detecção. Além do controle pressórico, quanto à reversão da anticoagulação, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

atividade anti-Xa calibrada para rivaroxabana abaixo do limite de detecção

Resolução. Hemorragia intracerebral em quem usa inibidor do fator Xa evoca o antídoto específico, e o andexanet é a armadilha de quem faz o degrau mais caro por reflexo. A reversão só faz sentido se ainda houver droga circulando: as diretrizes a indicam quando a última dose foi há menos de cerca de 24 a 48 horas ou quando o nível anti-Xa é mensurável. Aqui são 60 horas desde a última dose, com função renal normal (meia-vida da rivaroxabana de 5 a 13 horas) e atividade anti-Xa indetectável: não há anticoagulante a reverter. Andexanet aumenta eventos trombóticos (como no ANNEXA-I), e complexo protrombínico também é pró-trombótico; dar qualquer um sem droga circulante é só risco. A conduta é controle pressórico (PAS em torno de 140 mmHg) e cuidados habituais.

A) Nenhum agente reversor CORRETA

Correta. Sessenta horas após a dose, com rim normal e anti-Xa indetectável, não há efeito anticoagulante a reverter.

B) Andexanet alfa em bolus e infusão ARMADILHA

Errada, é a armadilha. Andexanet seria a escolha com dose nas últimas horas ou anti-Xa mensurável; sem droga circulante, só acrescenta trombose.

C) Complexo protrombínico 50 UI/kg

Errada. Complexo protrombínico é a alternativa ao andexanet quando há efeito residual; aqui não há, e ele também é pró-trombótico.

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg
Errada. Plasma não reverte inibidor do fator Xa em nenhuma situação e carrega volume e risco transfusional.

Para levar. Antes de reverter um anticoagulante oral direto, pergunte quando foi a última dose e se há nível mensurável; passadas 48 horas com rim normal ou com anti-Xa indetectável, não há o que reverter.

AHA/ASA 2022 Guideline for the Management of Patients With Spontaneous Intracerebral Hemorrhage; ESO Guideline on reversal of oral anticoagulants in acute intracerebral haemorrhage 2019; Connolly SJ et al. ANNEXA-I, N Engl J Med 2024.

---

49 Nefrologia · Vancomicina na bacteremia por MRSA · monitorar pela AUC de 24 horas de 400 a 600, e não pelo vale de 15 a 20

Grade X / Y **Gabarito C**

Na bacteremia por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, tratada com vancomicina em adulto com função renal estável, o parâmetro recomendado para monitorar a dose e o seu alvo, para reduzir a nefrotoxicidade sem perder eficácia, são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

para reduzir a nefrotoxicidade sem perder eficácia

Resolução. O vale de 15 a 20 mg/L foi a regra por mais de uma década e é o que fica na memória. A revisão de 2020 do consenso das sociedades americanas de farmácia e infectologia abandonou o vale como alvo nas infecções graves por MRSA: para chegar a 15 a 20, a exposição total costuma passar muito da necessária, e a nefrotoxicidade cresce com a AUC acima de 600 a 800 mg·h/L. O alvo passou a ser a AUC de 24 horas de 400 a 600 mg·h/L (assumindo CIM de 1), estimada de preferência por software bayesiano com uma ou duas dosagens. Vale baixo, entre 10 e 15, é o caminho da subdosagem, e AUC acima de 600 é o da lesão renal.

A) Nível de vale / 15 a 20 mg/L ARMADILHA
Errada. Era a recomendação de 2009; persegui-lo aumenta a lesão renal sem ganho de eficácia, e o consenso de 2020 o abandonou.

B) Nível de vale / 10 a 15 mg/L
Errada. Nas duas metades: o vale não é mais o parâmetro, e esse valor isolado não garante a exposição eficaz.

C) AUC de 24 horas / 400 a 600 mg·h/L CORRETA
Correta. AUC de 24 horas entre 400 e 600 mg·h/L, de preferência por estimativa bayesiana.

D) AUC de 24 horas / 600 a 800 mg·h/L
Errada. O parâmetro está certo, mas a faixa acima de 600 é justamente a associada à nefrotoxicidade.

Para levar. Vancomicina em infecção grave por MRSA: alvo de AUC de 24 horas entre 400 e 600 mg·h/L, e não vale de 15 a 20.

Rybak MJ et al. ASHP/IDSA/PIDS/SIDP consensus on therapeutic monitoring of vancomycin for serious MRSA infections, 2020.

---

50 Infectologia · Histoplasmose disseminada na aids em quem trata tuberculose: itraconazol só depois de trocar rifampicina por rifabutina

Droga a deduzir **Gabarito C**

Homem de 31 anos, com aids (CD4 45 células/mm³), trata tuberculose pulmonar há 4 semanas com o esquema básico de 4 drogas em dose fixa combinada. Iniciou há 2 semanas tenofovir, lamivudina e dolutegravir 50 mg de 12/12 horas. Foi internado com febre, pancitopenia, hepatoesplenomegalia e lesões papulares na face; antígeno de Histoplasma na urina reagente. Recebeu anfotericina B lipossomal por 2 semanas, com melhora clínica, afebril, sem acometimento do SNC. A equipe planeja passar para a fase de consolidação oral. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

dolutegravir 50 mg de 12/12 horas

Resolução. Itraconazol na dose de consolidação é o tratamento correto da histoplasmose depois da anfotericina, e por isso a opção que apenas o prescreve atrai. O dado a deduzir está na posologia da TARV: dolutegravir de 12/12 horas significa indutor potente associado, e o esquema básico da tuberculose contém rifampicina. A rifampicina induz o CYP3A4 e reduz os níveis de itraconazol a valores indetectáveis, o que leva à falha da histoplasmose; o mesmo ocorre com voriconazol (combinação contraindicada) e, em menor grau, com fluconazol, que ainda é menos eficaz na histoplasmose. A saída recomendada é trocar a rifampicina por rifabutina, indutor fraco, e então usar itraconazol com dosagem de nível sérico, ajustando a rifabutina pela interação. Com a troca, o dolutegravir volta a 50 mg uma vez ao dia, pois a rifabutina não exige dose dobrada.

A) Itraconazol 200 mg de 12/12 h, mantendo os esquemas ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a droga certa para a histoplasmose, mas a rifampicina do esquema básico derruba o nível de itraconazol e leva à falha.

B) Fluconazol 800 mg/dia, mantendo os esquemas
Errada. O fluconazol é alternativa menos eficaz na histoplasmose e também tem o nível reduzido pela rifampicina.

C) Itraconazol, trocando rifampicina por rifabutina CORRETA
Correta. Trocar a rifampicina por rifabutina permite o itraconazol em nível terapêutico, com dosagem sérica e ajuste da rifabutina.

D) Voriconazol, mantendo os esquemas
Errada. Voriconazol com rifampicina é combinação contraindicada pela indução intensa, além de não ser primeira linha na histoplasmose.

Para levar. Rifampicina e azólicos não convivem: na histoplasmose com tuberculose, a consolidação com itraconazol exige trocar rifampicina por rifabutina e dosar o nível sérico.

NIH/CDC/IDSA Guidelines for Prevention and Treatment of Opportunistic Infections in Adults with HIV, histoplasmose (atualização 2024); Ministério da Saúde, PCDT HIV adultos, módulo 2 (2023).